Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO PERFURATIVO

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! Dando sequência ao tema "Abdome Agudo", agora vamos falar sobre o abdome agudo perfurativo. Você verá no gráfico abaixo que não é muito frequente questões sobre perfuração intestinal, mas o que cai não costuma ser difícil. Guarde essas palavrinhas: dor abdominal súbita, úlcera péptica, rotina radiológica de abdome agudo, pneumoperitônio e laparotomia!!! Pronto! Você já consegue resolver a maioria das questões sobre abdome agudo perfurativo!

Estratégia MED

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

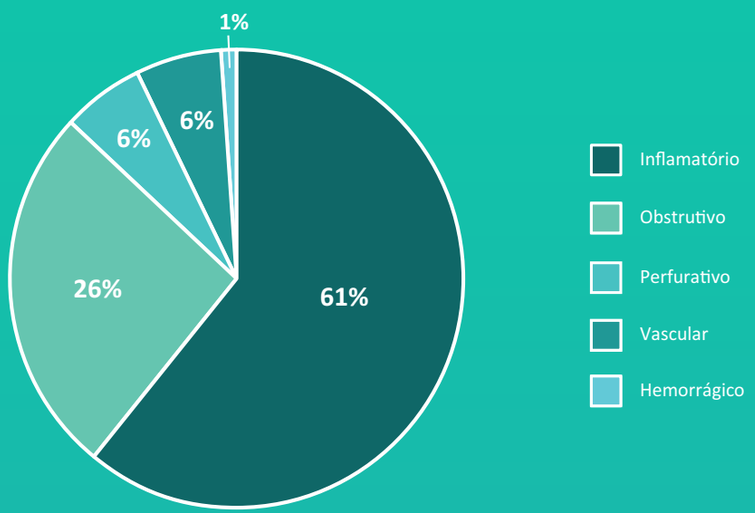
@estrategiamed

t.me/estrategiamed

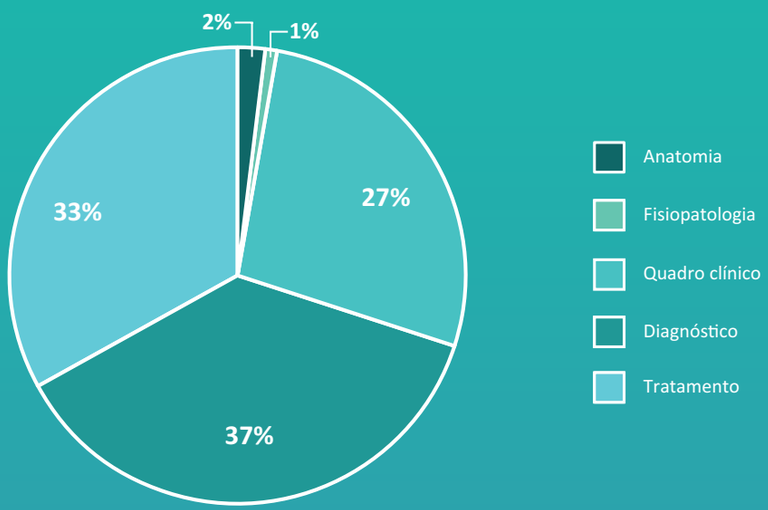
/estrategiamed

Estratégia MED

ABDOME AGUDO



ABDOME AGUDO PERFURATIVO



E o que seria um abdome agudo perfurativo? É a perfuração da espessura total da parede de uma víscera oca do trato gastrointestinal, com consequente extravasamento do seu conteúdo (gás, secreção gástrica, biliosa, entérica, fecaloide) para a cavidade peritoneal ou retroperitoneal. Então, podemos ter perfuração desde o esôfago até o reto, com as mais diversas causas, desde iatrogênicas durante a realização de exames (CPRE, colonoscopia, endoscopia), úlceras pépticas (mais comum), perfuração por corpo estranho, devido à obstrução intestinal, consequente a um abdome agudo inflamatório (apendicite, diverticulite) ou isquêmico.

SUMÁRIO

1.0 ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 EPIDEMIOLOGIA 5

1.3 TIPOS DE PERFURAÇÃO 5

1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 6

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES 7

1.5.1 EXAMES LABORATORIAIS 7

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM 7

1.6 TRATAMENTO 16

2.0 OUTRAS CAUSAS DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO 29

3.0 OUTRAS CAUSAS DE PNEUMOPERITÔNIO 35

4.0 LISTA DE QUESTÕES 37

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 39

CAPÍTULO
1.0 ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA

1.1 INTRODUÇÃO

A causa mais comum do abdome agudo perfurativo é a úlcera péptica perfurada. A fisiopatologia, os fatores de risco para a formação da úlcera péptica e o tratamento clínico serão abordados no livro de "Doença ulcerosa péptica".

Neste capítulo, vamos focar apenas no quadro clínico, diagnóstico e tratamento da úlcera péptica perfurada.

1.2 EPIDEMIOLOGIA

Os principais fatores de risco para a formação da úlcera péptica são:

- **infecção pelo *H. pylori*;**
- **uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINE)** ou do **ácido acetil salicílico (AAS)**;
- tabagismo e o álcool.

A doença ulcerosa péptica é mais comum em homens, e as úlceras duodenais mais frequentes do que as gástricas. A incidência da úlcera aumenta com a idade, sendo que as úlceras duodenais acometem principalmente pacientes mais jovens, entre 20 e 50 anos, e as gástricas têm um pico de incidência entre 55 e 65 anos. Dentre as possíveis complicações da úlcera péptica, a perfuração é a **segunda mais frequente** (a primeira é o sangramento), e que apresenta maior taxa de mortalidade, podendo chegar a 15%.

As úlceras da parede anterior do bulbo duodenal (1ª porção) são as responsáveis pela maioria das perfurações, seguidas pelas úlceras pré-pilóricas.



AS ÚLCERAS QUE MAIS PERFURAM SÃO AS DA **PAREDE ANTERIOR** DO BULBO DUODENAL.
AS ULCERAS QUE MAIS SANGRAM SÃO AS DA PAREDE POSTERIOR DO BULBO DUODENAL.

1.3 TIPOS DE PERFURAÇÃO

A perfuração de uma úlcera péptica pode ocorrer de várias maneiras, o que interfere na apresentação clínica. São elas:

✓ **Perfuração livre**: quando a secreção gástrica/duodenal "cai" na cavidade abdominal, causando peritonite difusa e dor de forte intensidade.

✓ **Perfuração bloqueada**: quando os órgãos adjacentes ou o omento bloqueiam a úlcera e, dessa forma, a apresentação clínica não é tão aguda e intensa. Pode ocorrer a formação de abscessos ou fístulas, por exemplo, entre o estômago e o duodeno, entre o duodeno e o cólon.

✓ **Úlcera terebrante ou penetrante**: quando a perfuração é bloqueada por órgãos adjacentes, como o pâncreas, baço, fígado ou cólon transverso. Nas úlceras duodenais, a penetração é mais frequente para o pâncreas, inclusive podendo cursar com pancreatite aguda.

1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

O quadro clínico clássico da úlcera péptica perfurada é **dor abdominal de início súbito, de forte intensidade, na região epigástrica**, que geralmente se irradia para todo o abdome. Pode apresentar náuseas, vômitos e sinais sistêmicos, como taquicardia, taquipneia e hipotensão arterial. É comum o paciente dizer a hora exata em que ocorreu a perfuração.

Como o pH do conteúdo gástrico é de 1 a 2, uma liberação repentina desse ácido no abdome causa irritação peritoneal intensa.

No exame físico, percebemos um paciente quieto, imóvel, pois a movimentação piora a dor. O abdome é **tenso, "em tábua",** com contração muscular involuntária, descompressão brusca localizada ou difusa, devido à irritação peritoneal. À percussão abdominal, pode ser encontrado o **sinal de Jobert**, que é a presença de timpanismo, ao invés da macicez hepática habitual, devido ao pneumoperitônio. Os ruídos hidroaéreos geralmente estão diminuídos.

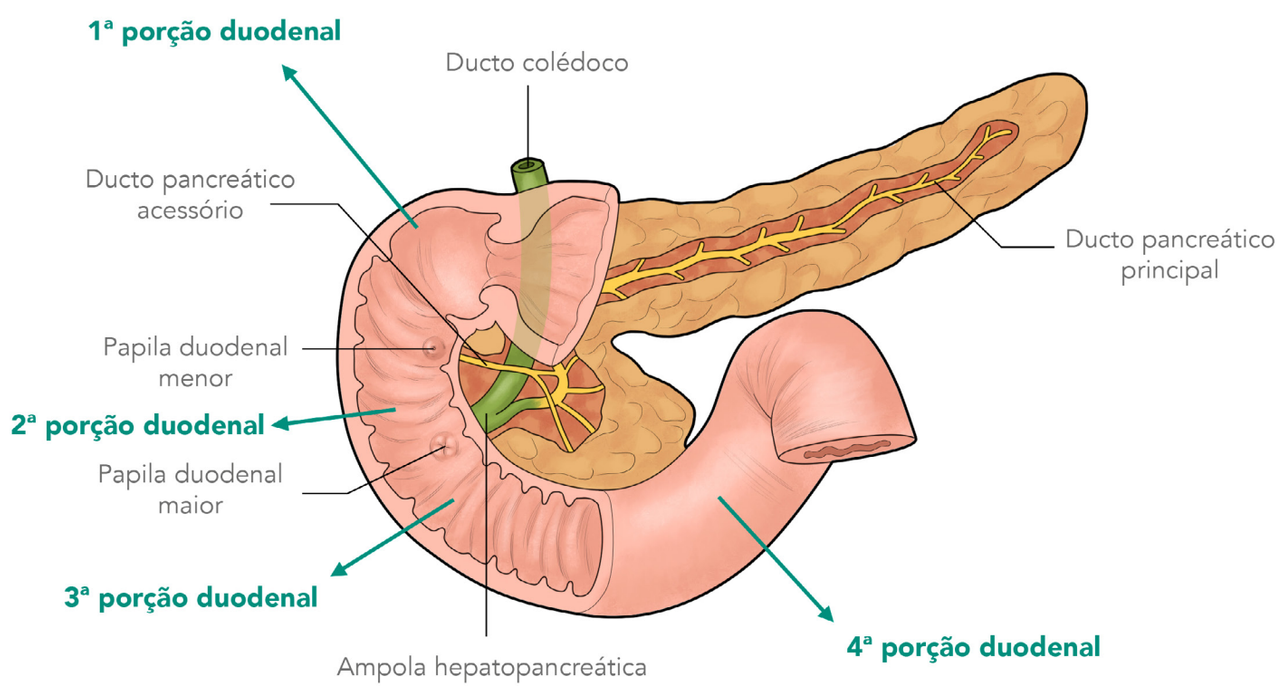


SINAL DE JOBERT

PRESENÇA DE TIMPANISMO AO INVÉS DA MACICEZ NA LOJA HEPÁTICA = PNEUMOPERITÔNIO.

Se a perfuração for bloqueada ou retroperitoneal, os sintomas são menos intensos quando comparados às perfurações intraperitoneais livres. Por exemplo, na perfuração duodenal retroperitoneal (2ª, 3ª e 4ª porção), o paciente pode não apresentar dor abdominal intensa e sinais de peritonite, e iniciar o quadro clínico com dor em região dorsal. Além disso, na perfuração de víscera oca retroperitoneal, podemos encontrar crepitação em fundo de saco posterior ao exame de toque retal. Vamos recordar as quatro porções do duodeno:

- ✓ 1ª porção: parte superior -> intraperitoneal (flexura duodenal superior);
- ✓ 2ª porção: parte descendente -> retroperitoneal (flexura duodenal inferior);
- ✓ 3ª porção: parte horizontal -> retroperitoneal;
- ✓ 4 ª porção: parte ascendente ->retroperitoneal (flexura duodenojejunal).



Devemos lembrar que um dos principais diagnósticos diferenciais de uma úlcera péptica perfurada é a pancreatite aguda. Ela, geralmente, apresenta-se com dor no andar superior do abdome, de forte intensidade, “em faixa”, com irradiação para o dorso, sendo a maioria dos casos de etiologia biliar. Mas, na pancreatite aguda, a amilase geralmente está aumentada pelo menos 3 vezes o valor superior da normalidade e não apresenta pneumoperitônio nos exames de imagem.

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES

1.5.1 EXAMES LABORATORIAIS

A depender do tempo de evolução, pode haver leucocitose com desvio à esquerda, aumento da PCR (proteína C reativa) e da amilase. O aumento da amilase pode estar presente, mas não é tão marcante como na pancreatite aguda.

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM

RADIOGRAFIA SIMPLES



O diagnóstico do abdome agudo perfurativo é baseado na história clínica, exame físico e confirmado por meio de um exame de imagem que demonstre a presença de **PNEUMOPERITÔNIO**, visualizado como ar subdiafragmático. Logo, na suspeita de um abdome agudo perfurativo, **o primeiro exame de imagem a ser solicitado é a rotina radiológica de abdome agudo**.

Vamos recordar as incidências da rotina radiológica do abdome agudo:

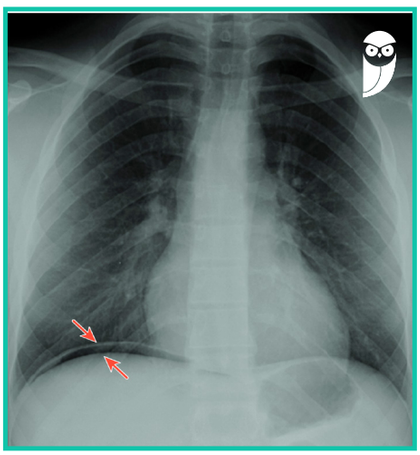
ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) em pé (ortostase).

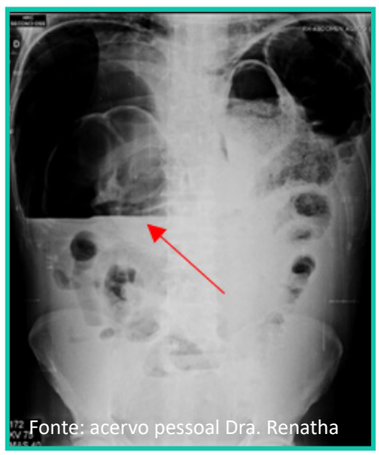
Radiografia de abdome anteroposterior (AP) em pé e deitado (decúbito dorsal).

O pneumoperitônio pode ser visto na radiografia de tórax em posição ortostática e está presente em até 75% das úlceras duodenais perfuradas. Na radiografia simples, é possível detectar apenas 1 mL de ar livre na cavidade. Em pacientes que não conseguem ficar de pé, podemos realizar a radiografia de abdome em decúbito lateral com raios horizontais, em que 5 a 10 mL de ar podem ser vistos. O que precisa ficar claro é que, diante de um paciente com dor abdominal e pneumoperitônio visualizado na radiografia simples de tórax ou abdome, já temos o diagnóstico de abdome agudo perfurativo e devemos indicar o tratamento cirúrgico, não sendo necessário nenhum outro exame de imagem.

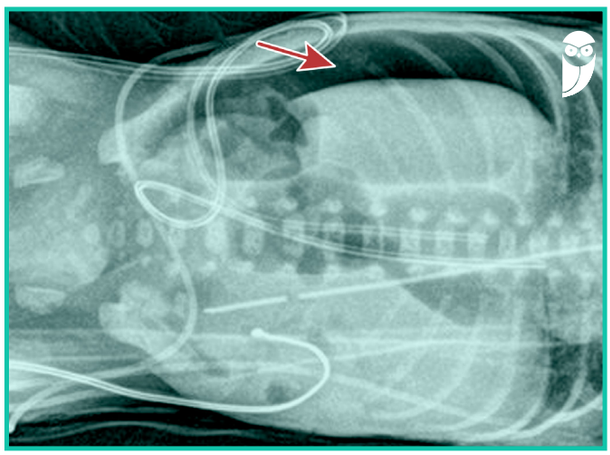
Mas preste atenção: a ausência de pneumoperitônio não exclui o diagnóstico de abdome agudo perfurativo!



Pneumoperitônio



Pneumoperitônio volumoso.

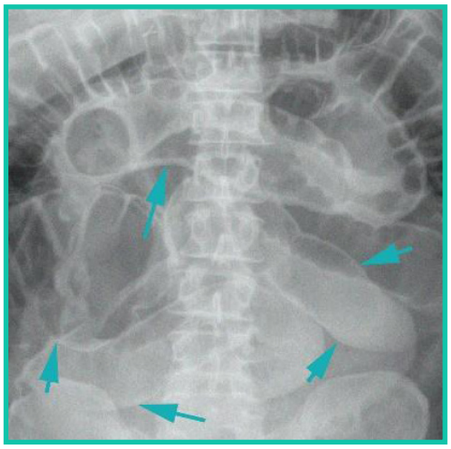


Pneumoperitônio: incidência com raios horizontais



SINAL DE RIGLER

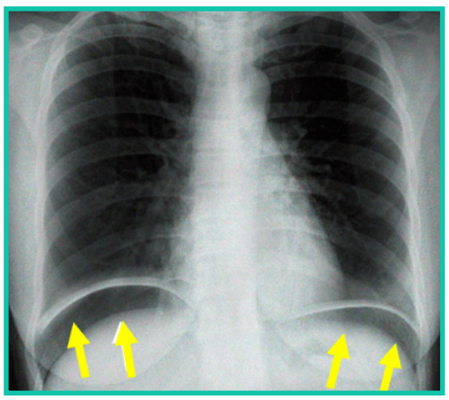
Também conhecido como "sinal da dupla parede". É um sinal radiológico que se refere à visualização, na radiografia de abdome, da parede gástrica ou intestinal (superfície interna e externa) devido à presença de gás na cavidade abdominal (pneumoperitônio).



Sinal de Rigler.



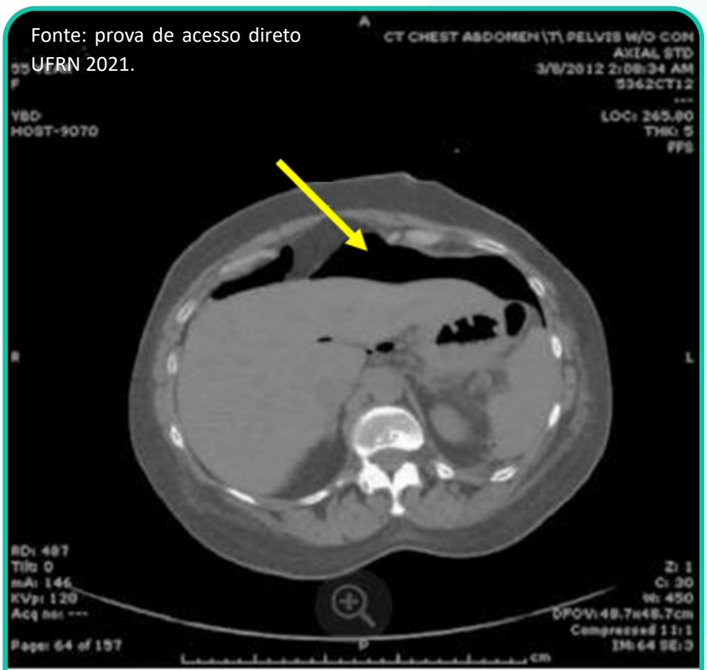
Sinal de Rigler ou sinal da dupla parede.



Sinal das "asas da gaivota".

Apesar de não ser um epônimo que usamos no nosso dia a dia, já foi cobrado em prova o "sinal de Popper", que é a imagem radiográfica correspondente ao sinal de Jobert, ou seja, a visualização do pneumoperitônio. Aproveitando as raridades, também existe o sinal das "asas da gaivota", que seria a visualização do pneumoperitônio bilateralmente.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

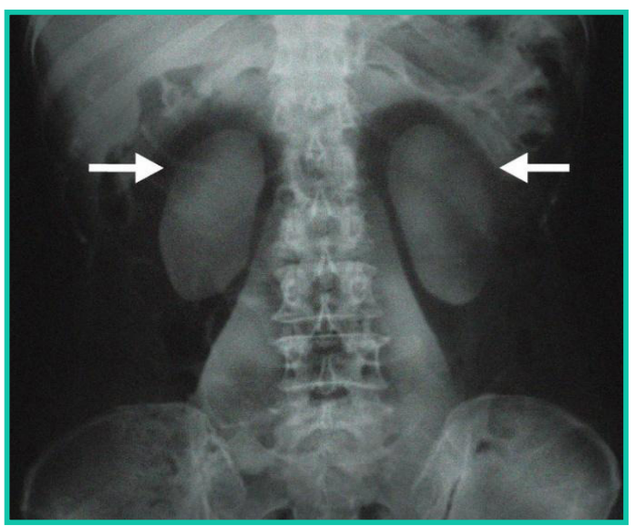


TC: pneumoperitônio.

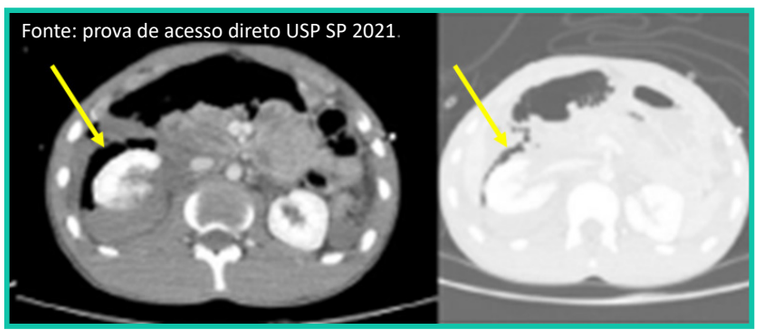
A tomografia de abdome é considerada o melhor exame para o diagnóstico do abdome agudo perfurativo, pois pode demonstrar quantidades menores de ar intracavitário. Além do pneumoperitônio, a tomografia identifica bem um retropneumoperitônio e é possível visualizar complicações associadas à perfuração, como abscesso intra-abdominal ou formação de fístula gastrointestinal. Mas, preste atenção: **o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de uma perfuração intestinal é rotina radiológica de abdome agudo; a tomografia fica reservada para os casos em que o pneumoperitônio não for visualizado na radiografia simples.**

Não é necessário o uso de contraste para identificação do pneumoperitônio na tomografia de abdome.

Devemos lembrar que a maior parte do duodeno é retroperitoneal (2ª, 3ª e 4ª porção). Dessa forma, perfurações nessas regiões podem apresentar retropneumoperitônio, que é melhor visualizado na tomografia, mas pode, ocasionalmente, ser identificado na radiografia simples de abdome.



Rx: retropneumoperitônio



TC: retropneumoperitônio.

ULTRASSONOGRAFIA

Apesar da ultrassonografia poder identificar o pneumoperitônio, não é o melhor exame para essa finalidade, além de ser examinador-dependente.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

A endoscopia digestiva alta (EDA) **NÃO DEVE** ser realizada na suspeita de uma perfuração de úlcera péptica, pois a insuflação de ar pode "destamponar" uma úlcera perfurada e bloqueada.

RADIOGRAFIA CONTRASTADA

Os exames contrastados, principalmente com o uso do bário, devem ser evitados, pois o bário pode causar uma peritonite química, altamente letal. Se for indicado um exame contrastado, que seja feito com contraste hidrossolúvel, pois, caso ocorra desbloqueio da perfuração, é muito menos pernicioso do que o bário.

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - (PRÓ-MFC) - UERJ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - HUPE) 2023) Paciente de 32 anos chega ao consultório com queixa de dor abrupta de forte intensidade em região epigástrica, iniciada há dois dias e sem melhora com analgesia comum (dipirona e diclofenaco). A dor piorou, estando agora em todo o abdômen, que se apresenta em tábua e muito doloroso difusamente. A rotina de abdômen agudo mostra pneumoperitônio. O diagnóstico provável é:

A) úlcera péptica perfurada.
B) pancreatite aguda.
C) diverticulite.
D) apendicite.

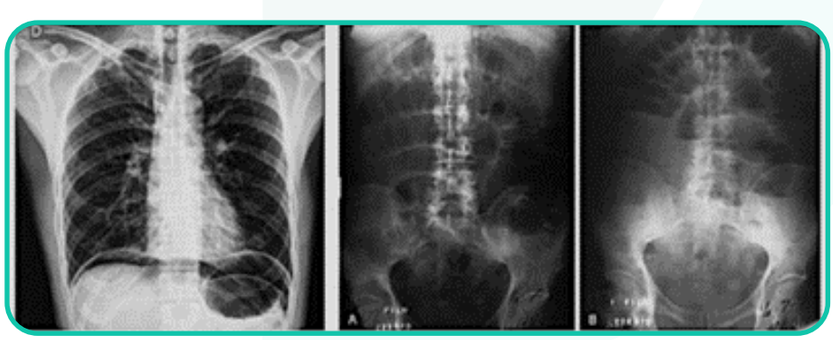
Comentários

Estamos diante de um paciente com quadro clínico típico de abdome agudo perfurativo por úlcera péptica perfurada: dor epigástrica súbita, de forte intensidade e abdome "em tábua" ao exame físico. O diagnóstico é confirmado com a presença de pneumoperitônio à radiografia de abdome agudo.

Correta a alternativa A: como vimos, esse é o diagnóstico provável.

Incorreta a alternativa B: pancreatite aguda é um dos principais diagnósticos diferenciais da úlcera péptica perfurada, mas não apresenta pneumoperitônio nos exames radiológicos.
Incorreta a alternativa C: na diverticulite aguda, a dor é na fossa ilíaca esquerda. Além disso, não apresenta pneumoperitônio.
Incorreta a alternativa D: na apendicite aguda, a dor é migratória da região periumbilical para a fossa ilíaca direita. Além disso, não apresenta pneumoperitônio.

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - SCMMA 2023) Paciente masculino, 30 anos, encaminhado da unidade de pronto atendimento de nível secundário devido à hipótese de abdome agudo obstrutivo por bridas. Queixa-se de dor abdominal súbita há 8 horas, intensa, em facada, em andar superior do abdome, associada a um episódio de vômito, com piora progressiva durante a observação, sem melhora com analgésicos. Nega trauma recente. Tem histórico de laparotomia prévia por ferimento de arma de fogo. Ao exame físico: regular estado geral, desidratado, taquicárdico, afebril. Semiologia cardiopulmonar normal. Abdome distendido, doloroso difusamente, tenso, com defesa involuntária à palpação. São realizadas as radiografias de abdome agudo abaixo. A principal hipótese diagnóstica é:



A) úlcera péptica perfurada.
B) pancreatite.
C) apendicite.
D) ureterolitíase.

Comentários

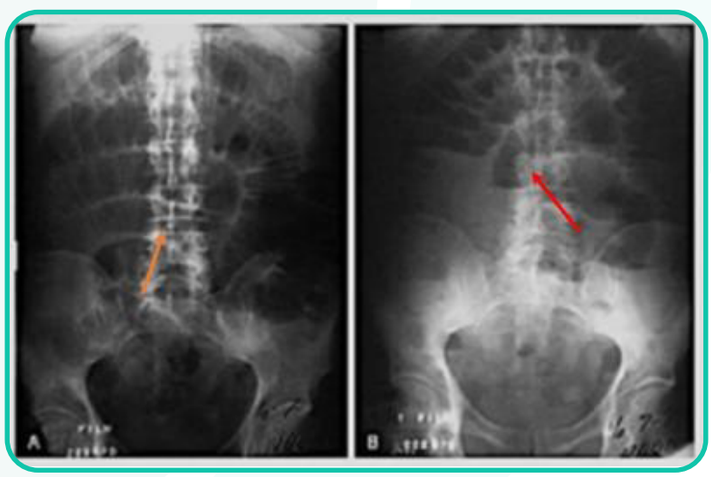
Essas são as características típicas de um abdome agudo perfurativo, cuja principal causa é a úlcera péptica perfurada.

Geralmente, a dor é súbita, no abdome superior, de forte intensidade (é comum o paciente dizer exatamente a hora em que a dor começou), que logo se irradia para todo o abdome. Ao exame físico, encontramos um paciente quieto, imóvel, taquicárdico, sudoreico, com abdome tenso, "em tábua", com sinais de peritonite difusa (descompressão brusca dolorosa em todo o abdome).

Podemos encontrar o sinal de Jobert, que seria a presença de timpanismo, ao invés da macicez hepática, à percussão do hipocôndrio direito. O diagnóstico do abdome agudo perfurativo geralmente é confirmado com a rotina radiológica de abdome agudo, com a visualização do pneumoperitônio.



Nessa radiografia de tórax, é possível ver o acúmulo de ar subdiafragmático bilateralmente, principalmente à direita (seta laranja). Além disso, é excelente para ensinar o sinal de Rigler, pois a parede interna e externa do estômago é facilmente identificável (seta vermelha). Repare, em outras radiografias, que você quase nunca consegue desenhar de forma tão nítida a parede do estômago.



Essas são as caraterísticas típicas de uma radiografia com obstrução de delgado. As alças distendidas são centrais, apresentam válvulas conniventes, nível hidroaéreo e o tamanho da distensão é inferior ao da distensão do cólon. Nesse caso, o achado provavelmente é secundário à peritonite/doença ulcerosa péptica perfurada.

Correta a alternativa A.

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HC) 2023) Mulher, 63 anos de idade, refere dor abdominal de forte intensidade, difusa e de início súbito há 2 horas. Nega vômitos. Última evacuação há 1 dia. Tem artrite reumatoide. Faz uso de um imunossupressor e corticoide. Na última semana, tomou cetoprofeno devido à dor nas mãos. Ao exame clínico, encontra-se em regular estado geral; FC 110 bpm; PA 100 x 60 mmHg; abdome plano, doloroso à palpação; e sinal de irritação peritoneal difusa.

Exames laboratoriais: Hb 11,9 g/dL; Ht 32%; leucócitos 18.318/mm³; PCR 84 mg/L; amilase 251 U/L; lipase 101 U/L.

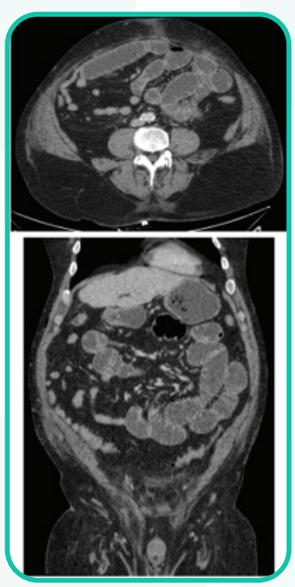
Foi realizada tomografia de abdome.

Assinale a alternativa que contém imagens que correspondem à principal hipótese diagnóstica?

A)



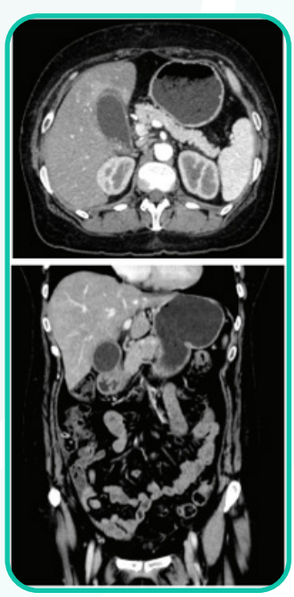
C)



B)



D)



Comentários

Estamos diante de um típico quadro de abdome agudo perfurativo: dor abdominal intensa, difusa e de início súbito há 2 horas. Relato de uso de um imunossupressor e corticoide, além de cetoprofeno devido à dor nas mãos. Abdome plano, doloroso à palpação; e sinal de irritação peritoneal difusa.

O conjunto desses achados clínicos nos faz suspeitar de um abdome agudo perfurativo secundário a uma úlcera péptica perfurada. Agora, vamos analisar as imagens tomográficas para saber qual é condizente com nossa suspeita diagnóstica.

Correta a alternativa A: estamos diante de dois cortes tomográficos do abdome axial e coronal em uma janela direcionada para a avaliação do parênquima pulmonar. Pegue a dica do radiologista: a avaliação tomográfica do abdome em janela de parênquima pulmonar dedica-se principalmente à pesquisa de pneumoperitônio. O achado que vemos na imagem é um grande pneumoperitônio peri-hepático, o que é condizente com a hipótese de um abdome agudo perfurativo por úlcera.

Incorreta a alternativa B: os achados tomográficos são sugestivos com apendicite aguda não complicada e incondizentes com a suspeita diagnóstica. Reparem que vemos cortes tomográficos do abdome com contraste apresentando densificação da gordura na fossa ilíaca direita, hiper-realce da parede apendicular e distensão do apêndice.

Incorreta a alternativa C: os achados tomográficos são sugestivos de um abdome obstrutivo de delgado e incondizentes com a suspeita diagnóstica. Reparem que vemos cortes tomográficos do abdome com contraste apresentando distensão de alças de delgado, principalmente no mesogástrio, sem aumento de calibre do intestino grosso, além de densificação do subcutâneo na parede abdominal anterior, o que pode indicar manipulação cirúrgica prévia abdominal.

Incorreta a alternativa D: os achados tomográficos são sugestivos de colecistite aguda e incondizentes com a suspeita diagnóstica. Reparem que vemos cortes tomográficos do abdome com contraste apresentando cálculos na vesícula biliar, hiperdistensão dela, aumento da espessura de sua parede e distúrbio perfusional peri-hepático adjacente.

(RN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 2022) Homem de 40 anos com quadro agudo de dor súbita no epigástrio e irradiação para todo o abdome há seis horas, vômitos claros no início e parada da eliminação de gases. No exame físico, com contratura abdominal e com sinais de irritação peritoneal em todo o abdome. O exame complementar inicial a ser realizado será:

A) RNM do abdome.
B) Tomografia do abdome.
C) Ultrassom do abdome.
D) Radiografia de abdome.

Comentário:

Temos, aqui, um típico quadro de abdome agudo perfurativo! Uma paciente com dor abdominal súbita no abdome superior com irradiação para os demais quadrantes. Imagine que o líquido gástrico/duodenal escorre para o abdome inferior, causando irritação peritoneal difusa. O diagnóstico é comprovado pela presença de pneumoperitônio no exame de imagem, e o primeiro procedimento a ser realizado é a rotina radiológica de abdome agudo, em que está inclusa a radiografia de tórax em ortostase e de abdome em pé e deitado. Se persistir a dúvida, o próximo passo será uma tomografia de abdome. E, confirmada nossa suspeita diagnóstica, com a visualização do pneumoperitônio, o tratamento será cirúrgico (laparotomia ou laparoscopia).

A ultrassonografia não é o melhor exame para identificação do pneumoperitônio, além de ser dependente do examinador. A RNM certamente confirmaria o diagnóstico, mas é um exame de alto custo e com baixa disponibilidade na maioria dos serviços.

Gabarito: alternativa D

(SANTA CASA SP 2019) Um paciente de 45 anos de idade apresenta dor epigástrica súbita e vômitos há doze horas, com piora progressiva. Ao exame físico, estava em regular estado geral, pálido e taquicárdico, com dor à palpação em todo o abdome e defesa muscular. Realizou radiografia de tórax com cúpulas, sem alterações. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

A) É indicado tratamento operatório de emergência por tratar-se de pancreatite aguda.
B) Trata-se de infarto agudo do miocárdio que deve ser encaminhado para tratamento com estreptoquinase.
C) Se a dosagem de amilase for normal, o diagnóstico será de apendicite aguda complicada.
D) Deve-se solicitar ultrassonografia de abdome devido à possibilidade de diverticulite aguda.
E) Trata-se de abdome agudo perfurativo se tiver pneumoperitôneo na tomografia de abdome.

Comentário:

Bom, nessa questão, temos um paciente com dor epigástrica súbita, vômitos e defesa muscular, quadro clínico sugestivo de um abdome agudo perfurativo. Foi realizada a radiografia de tórax que não evidenciou pneumoperitônio, o que não exclui o diagnóstico. Qual será o próximo passo? Uma tomografia computadorizada que é altamente sensível e específica para identificar pneumoperitônio e descartar possíveis diagnósticos diferenciais, como a pancreatite aguda, dentre outros. Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: para o diagnóstico da pancreatite aguda, são necessários alguns exames laboratoriais, como amilase e lipase, geralmente aumentada 3 vezes ou mais o valor superior da normalidade. Além disso, o tratamento da pancreatite aguda, a princípio, é clínico, com jejum, analgesia e hidratação endovenosa.

Incorreta a alternativa B: é possível um infarto agudo do miocárdio (IAM) cursar com dor epigástrica, mas não com dor à palpação em todo o abdome e defesa muscular. E o mínimo para o diagnóstico de um IAM é um ECG!

Incorreta a alternativa C: a amilase apresenta um aumento importante nos quadros de pancreatite aguda (3 vezes o valor superior da normalidade). Mas também pode estar aumentada em diversas causas, como no abdome agudo inflamatório, perfurativo e vascular.

Incorreta a alternativa D: além de acometer pacientes mais idosos, o quadro clínico da diverticulite aguda é diferente do apresentado, que seria a presença de dor em fossa ilíaca esquerda, podendo estar associada à anorexia e febre. E o melhor exame para o diagnóstico de uma diverticulite é a tomografia computadorizada de abdome.

Correta a alternativa E: na suspeita de um abdome agudo perfurativo com radiografia simples de tórax normal, devemos realizar uma tomografia de abdome, e, se essa evidenciar um pneumoperitônio, temos o diagnóstico.

(ABC 2018) A doença ulcerosa duodenal pode manifestar-se com dor, que geralmente alivia com a alimentação. Sangramento, que se manifesta com hematêmese ou melena, obstrução, que se manifesta com saciedade e plenitude ou pode perfurar em peritônio livre. A perfuração leva a perda de macicez hepática, que propedeuticamente se traduz pelo:

A) Sinal de Torres-Homem +
B) Sinal de Rovsing +

C) Sinal de Giordano +

D) Sinal de Jobert +

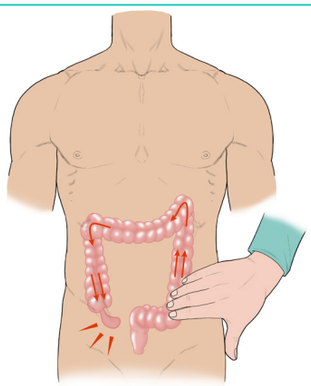
Comentário:

Correta a alternativa D

Na percussão abdominal de um paciente com abdome agudo perfurativo com pneumoperitônio, há perda da macicez hepática habitual no hipocôndrio direito e a presença de timpanismo, achado este conhecido como Sinal de Jobert. Vamos aproveitar essa questão para relembrar os sinais que estão nas alternativas.

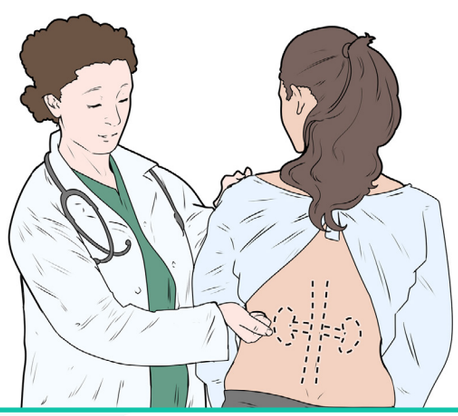
- Sinal de Torres-Homem: percussão dolorosa em região hepática, relacionado com abscesso hepático.
- Sinal de Rovsing: dor no quadrante superior direito à palpação do quadrante inferior esquerdo do abdome. Presente nos quadros de apendicite aguda.

SINAL DE ROVSING



- Sinal de Giordano: dor produzida pela punho-percussão na região lombar. Pode ser um sinal de pielonefrite aguda ou litíase renal.

SINAL DE GIORDANO



1.6 TRATAMENTO

Meu querido aluno, talvez você fique um pouco confuso quando eu falar das técnicas utilizadas para o tratamento da úlcera péptica. E realmente é um pouco difícil, mas algumas bancas adoram cobrar essas técnicas. Mas, calma! Vou fazer o possível para que você entenda tudo perfeitamente.

O primeiro ponto importante, que eu quero que você guarde: o tratamento da úlcera péptica perfurada **é CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA!**

É comum os pacientes já se apresentarem com repercussão hemodinâmica e choque séptico. Por esse motivo, é primordial **a reanimação antes da cirurgia**, de forma rápida e contínua, que consiste em reanimação volêmica com cristaloide, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos (se presentes), analgesia, iniciar antibióticos de largo espectro e, se necessário, drogas vasoativas. Claro que essa reanimação deve ser mantida no intra e no pós-operatório.

Nas perfurações causadas por úlcera péptica, os sucos digestivos que extravasam, levam inicialmente a uma **peritonite química**, seguida de proliferação bacteriana e consequente processo infeccioso. Dessa forma, até 12 horas da perfuração gástrica/duodenal, há uma reação inflamatória do peritônio com produção de exsudato inflamatório. Após esse período, há contaminação bacteriana e desenvolvimento de peritonite bacteriana secundária. Isso é importante, pois dependendo do tempo de evolução, há necessidade apenas de antibioticoprofilaxia, e não terapia.

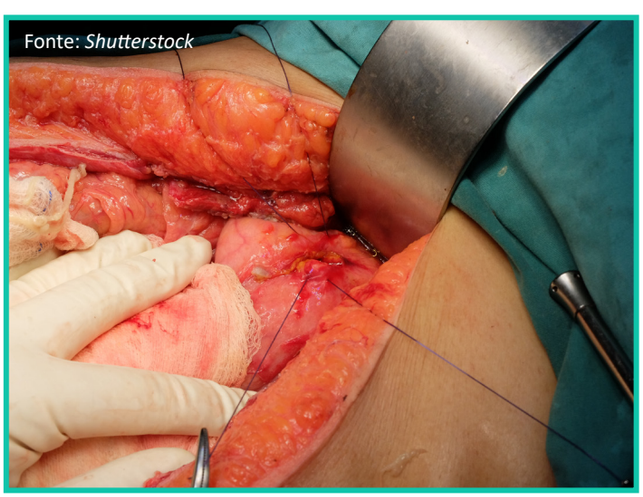
A via de acesso cirúrgico é feita por **laparotomia ou por laparoscopia** (desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente). A cirurgia a ser realizada vai depender da localização, tamanho da úlcera, tempo de evolução e, principalmente, das condições clínicas do paciente. Vamos abordar cada uma dessas situações e suas respectivas condutas:

1 - PACIENTES INSTÁVEIS, COM PERFURAÇÃO > 24 HORAS, PERITONITE DIFUSA E ALTO RISCO CIRÚRGICO:

- **Ulcerorrafia e epiploplastia (*patch* de omento ou *patch* de Graham) + lavagem da cavidade**. As bordas das **úlceras gástricas devem ser ressecadas ou ao menos biopsiadas** (para descartar neoplasia). A colocação de dreno abdominal vigilante não é utilizada de forma rotineira na cirurgia de uma úlcera péptica perfurada tratada apenas com rafia da lesão. Após a cirurgia, é importante fazer o tratamento do *H. Pylori,* caso seja positivo (realizar EDA, geralmente após 4 semanas de pós-operatório).

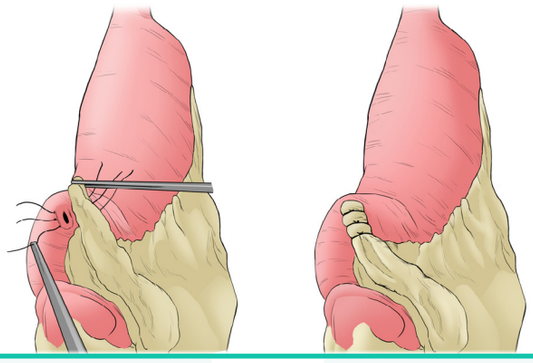


Úlcera gástrica pré-pilórica perfurada.



Ulcerorrafia.

Patch de Graham



TÉCNICA DO *PATCH* DE GRAHAM

Múltiplos pontos de sutura pegando tecido saudável próximo às bordas proximal e distal da úlcera são confeccionados.

O omento é posicionado por baixo desses pontos, que são amarrados, fixando-o sobre a lesão e selando a perfuração.

2 - PACIENTES ESTÁVEIS, COM PERFURAÇÃO < 24 HORAS, SEM PERITONITE DIFUSA E BAIXO RISCO CIRÚRGICO:

PARA ÚLCERAS DUODENAIS (HIPERCLORIDRIA):

De um modo geral, a perfuração está localizada na parede anterior do bulbo duodenal e apresenta menos de 5 mm de diâmetro. **O simples fechamento com *patch* de omento, acompanhado por irrigação peritoneal (5 a 10 litros de soro fisiológico aquecido), compõe o tratamento satisfatório na maioria dos pacientes.** A cirurgia definitiva para tratamento de úlceras duodenais perfuradas, como a vagotomia superseletiva ou vagotomia troncular, acompanhada de drenagem gástrica, é provavelmente desnecessária em muitos casos, mas sua realização deve ser considerada em pacientes que claramente não aderiram ao tratamento médico ou que apresentam histórico documentado de úlcera duodenal crônica significativa.

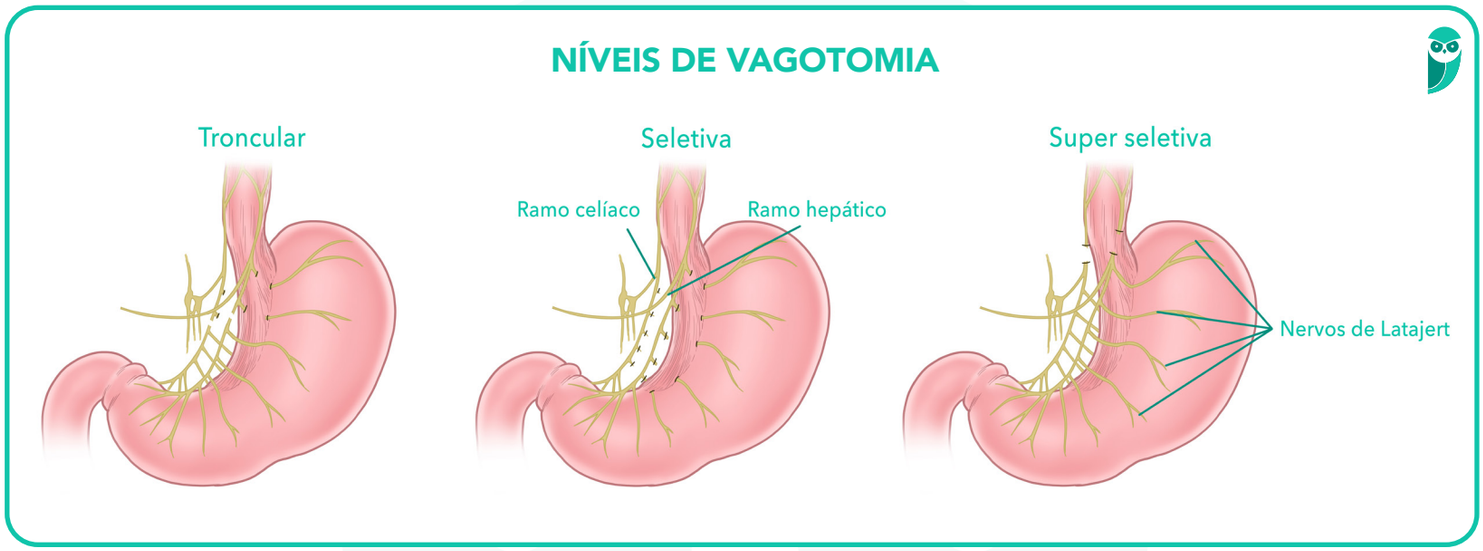
Nesses casos, além da rafia ou ressecção da úlcera, deve ser feita a cirurgia definitiva para o tratamento da úlcera péptica duodenal, visando reduzir a secreção ácida, portanto diminuir a taxa de recorrência. E como reduzir a secreção gástrica? Por meio da vagotomia, associada ou não à antrectomia. Veja a explicação:

Vagotomia = o nervo vago inerva o fundo gástrico, estimulando a produção de ácido pelas células parietais do corpo e fundo gástrico, e também faz a inervação parassimpática de todo o estômago e no piloro. Dessa forma, ele é responsável pelo relaxamento do piloro, permitindo a passagem do alimento do estômago para o duodeno. Uma vez feita a vagotomia troncular, o piloro fica contraído, dificultando o esvaziamento gástrico e produzindo estase gástrica. Por esse motivo, a vagotomia troncular sempre deve ser associada a um procedimento de drenagem gástrica (piloroplastia ou antrectomia).

Antrectomia = retirada do antro e, consequentemente, das células G produtoras de gastrina, diminuindo o estímulo à secreção ácida. É mais utilizada para o tratamento das úlceras gástricas. A reconstrução pode ser feita a Billroth I (gastroduodenostomia), Billroth II (gastrojejunostomia) e Y de Roux. A vagotomia troncular isolada reduz o pico de secreção ácida em 50% e a vagotomia associada à antrectomia diminui em aproximadamente 85%, tendo um menor índice de recorrência, porém maior morbidade e complicações pós-operatórias, como as síndromes pós-gastrectomias e pós-vagotomia.

Existem três opções cirúrgicas para a vagotomia:

a. Vagotomia troncular: consiste na secção dos nervos vagos direito e esquerdo, acima dos ramos hepático e celíaco e acima da junção gastroesofágica. Sempre associar um procedimento de drenagem.



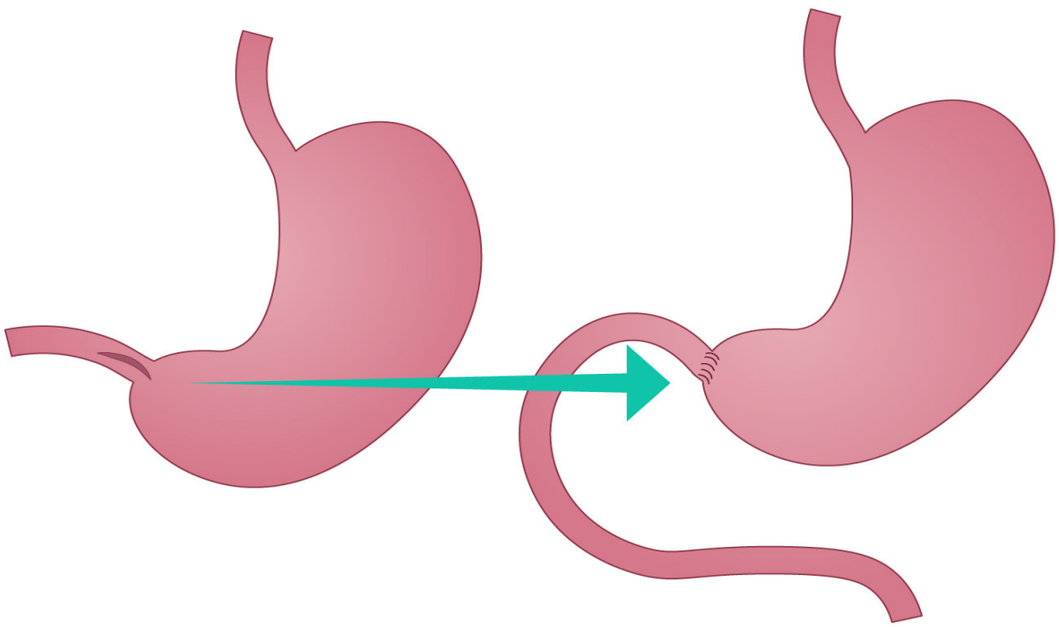
b. Vagotomia seletiva: praticamente está em desuso pela alta taxa de recidiva da doença ulcerosa, mais elevada que a vagotomia troncular e sem vantagens em relação à diminuição dos sintomas pós-gastrectomia. Consiste na secção dos nervos vagos direito e esquerdo logo abaixo dos ramos celíaco (sai do nervo vago direito) e hepático (sai do nervo vago esquerdo), sempre associada a um procedimento de drenagem gástrica.

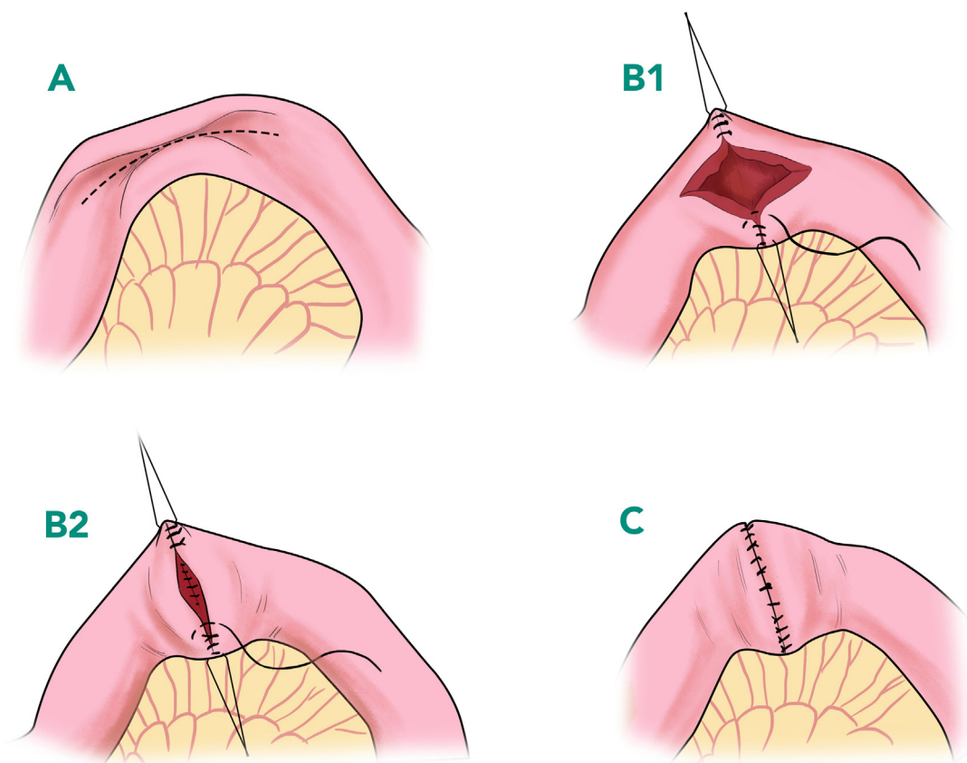
c. Vagotomia superseletiva: secciona somente as ramificações nervosas que inervam o fundo e o corpo gástrico (nervos de Latarjet), preservando a inervação vagal do antro e piloro. Tem a capacidade de diminuir a secreção ácida, mantendo o esvaziamento gástrico adequado, não sendo necessário associar um procedimento de drenagem gástrica. Na prática, é pouco utilizada, trabalhosa e apresenta maior índice de recorrência, no entanto tem menor morbimortalidade.

VAGOTOMIA	NERVOS SECCIONADOS	NECESSIDADE DE DRENAGEM GÁSTRICA	USO NA PRÁTICA
Troncular	Nervos vagos direito e esquerdo, acima dos ramos hepático e celíaco.	Sim	Mais utilizada (menor taxa de recidiva, porém maior morbidade e complicações pós-operatórias).
Seletiva	Nervos vagos direito e esquerdo, logo abaixo dos ramos celíaco e hepático.	Sim	Em desuso (alta taxa de recidiva).
Superseletiva	Ramificações nervosas que inervam o fundo e o corpo gástrico (nervos de Latarjet), preservando a inervação vagal do antro e piloro.	Não	Pouco utilizada (trabalhosa e alta taxa de recidiva).

E, para promover a drenagem gástrica, que deve ser realizada após a vagotomia, existem várias técnicas cirúrgicas, sendo a mais utilizada a piloroplastia à Heineke-Mikulicz. Essa técnica consiste na abertura longitudinal e no fechamento transversal do piloro, com o intuito de aumentar o diâmetro dele.

PILOROPLASTIA A HEINEKE - MIKULICZ

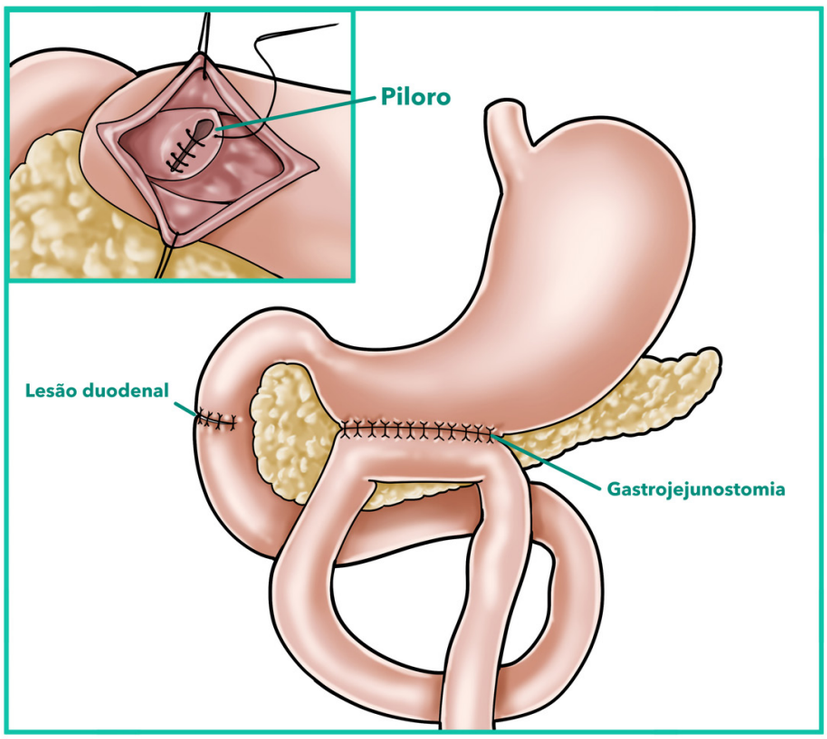




Técnica de Heineck Mikulicz: abre longitudinal e fecha transversal.

Não costuma ser cobrada em prova a conduta diante de úlceras duodenais mais complexas. Mas, acrescentei esse tratamento no nosso livro, porque meu objetivo é preparar você para acertar qualquer questão sobre úlcera péptica perfurada. Se a úlcera duodenal perfurada for grande, > 3 cm, seu fechamento pode ser mais difícil. Nesses casos, o defeito deve ser fechado com sobreposição do omento ou de serosa de alça jejunal em Y de Roux, associada à exclusão pilórica.

Exclusão pilórica - Cirurgia de Vaughan



EXCLUSÃO PILÓRICA OU CIRURGIA DE VAUGHAN

Consiste em abertura do estômago ao nível da grande curvatura do antro, cerclagem interna do piloro com fio absorvível (desfaz-se em algumas semanas) e uma gastroenteroanastomose a BII ou Y de Roux. O objetivo dessa cirurgia é deixar o duodeno reparado em "repouso" temporariamente, desviando o trânsito intestinal do duodeno, por meio da gastroenteroanastomose.

Outras opções cirúrgicas para o tratamento da úlcera duodenal complexa seriam:

- Colocação de um tubo de duodenostomia no local da úlcera e drenagem ampla da cavidade;
- Antrectomia (englobando a úlcera duodenal perfurada) com reconstrução a **BII** ou Y de Roux.

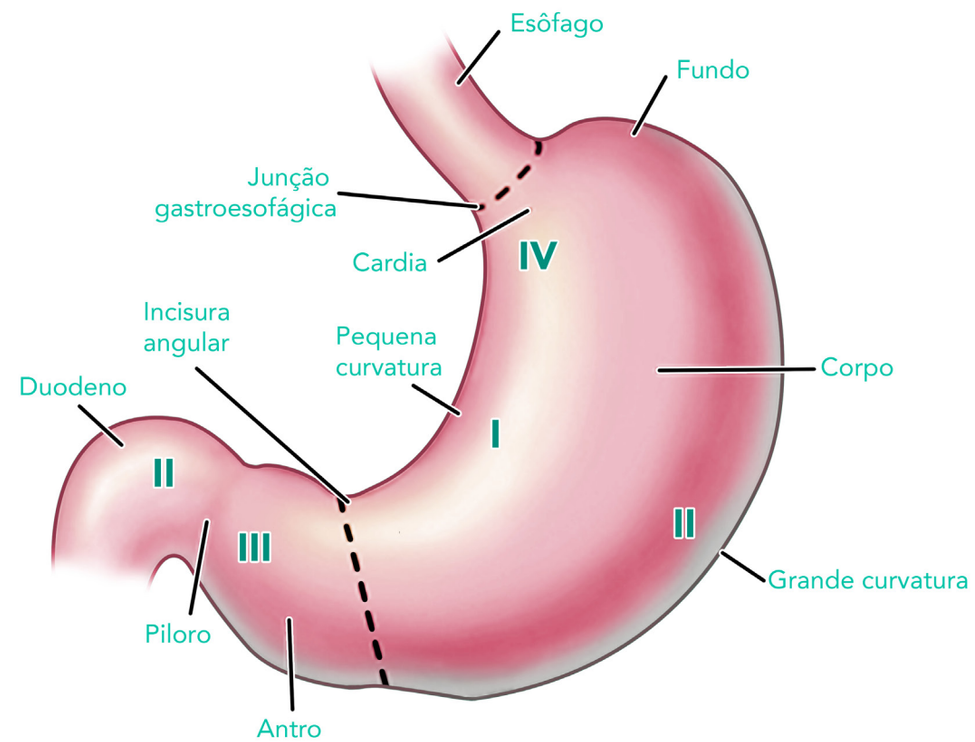
PARA ÚLCERAS GÁSTRICAS:

Devemos sempre ressecar a úlcera pelo risco de neoplasia. A extensão da ressecção vai depender do tamanho e da localização da úlcera (hipo ou hipercloridria), podendo ser realizada uma ressecção local em cunha, uma gastrectomia distal (antrectomia ou subtotal), ou até mesmo uma gastrectomia total, com reconstrução a BI, BII ou Y de Roux.



As úlceras gástricas gigantes, definidas como diâmetro ≥ 2 cm, geralmente estão localizadas na curvatura menor e têm uma maior incidência de neoplasia maligna (10%) do que as úlceras menores, além disso elas têm como tratamento de escolha a gastrectomia englobando a úlcera. A vagotomia deve ser associada nas úlceras com hipercloridria, ou seja, tipo II e III de Johnson. E, nas úlceras sem hipercloridria (úlceras tipo I e IV), não é necessária a vagotomia.

Para entender o tratamento definitivo da úlcera gástrica, vamos relembrar a classificação de Johnson, que é abordada no livro de "Doença ulcerosa péptica". Essa classificação baseia-se na localização anatômica e potencial do secretor de ácido da úlcera:

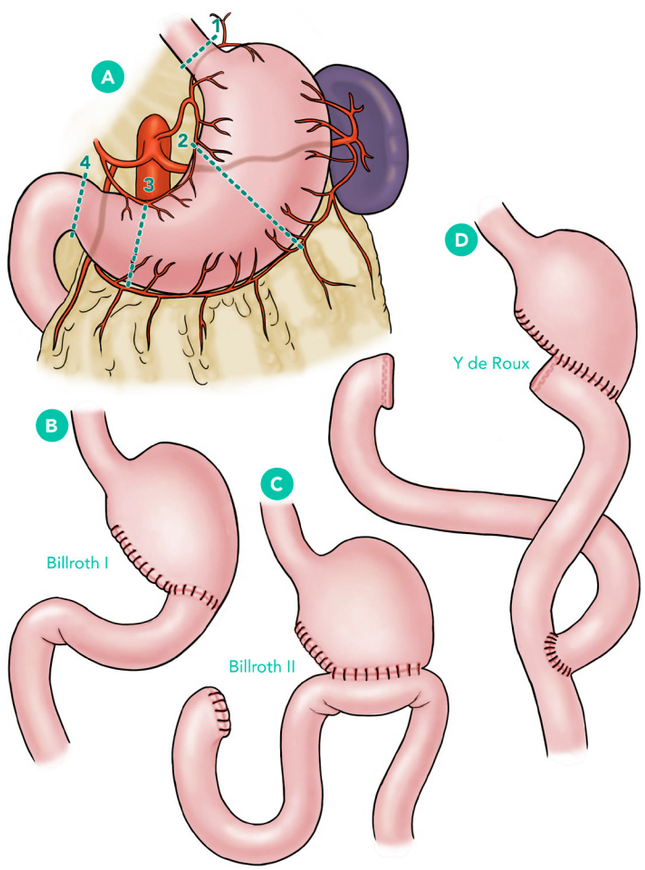


CLASSIFICAÇÃO DE JOHNSON - TIPOS DE ÚLCERA GÁSTRICA			
TIPO	**LOCALIZAÇÃO**	**NÍVEL DE ÁCIDO**	**CIRURGIA**
I	Pequena curvatura, incisura angular (60%).	Hipocloridria ou normal.	Gastrectomia distal.
II	Corpo gástrico com úlcera duodenal (15%).	Hipercloridria.	Gastrectomia distal com vagotomia troncular.
III	Pré-pilórica (20%).	Hipercloridria.	
IV	Parte alta da pequena curvatura, próxima à junção esofagogástrica (<10%).	Normal.	Gastrectomia total ou distal
V	Qualquer local.	Normal, induzido por AINE.	*Rafia e "*patch* de Graham".

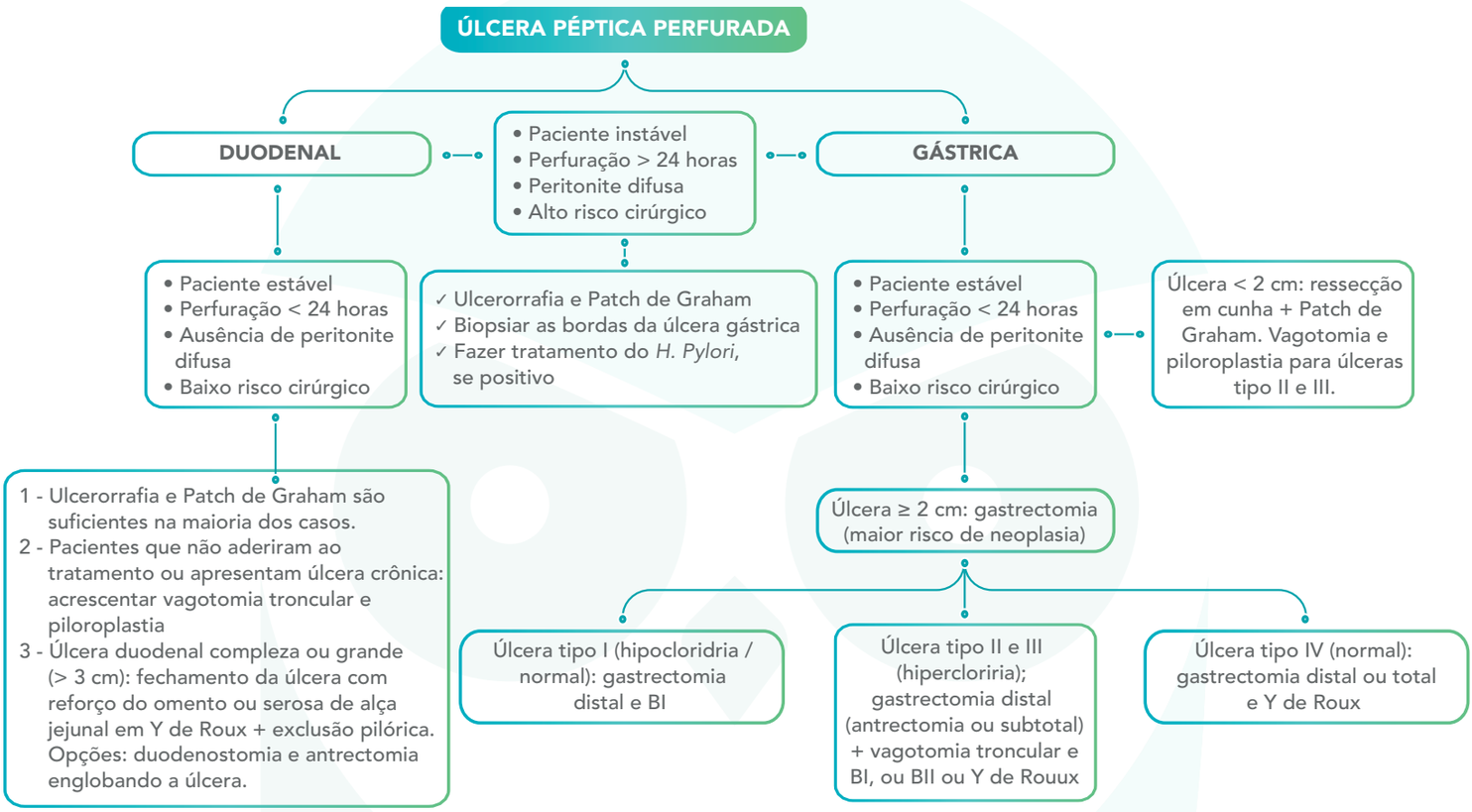


Nas úlceras agudas provocadas por AINE (sem calo ulceroso), a conduta é realizar apenas a rafia e o *patch* de omento.

Agora, vou lhe explicar as reconstruções pós-gastrectomias. Eu sei que, em um primeiro momento, parece ser difícil. Mas veja esta imagem, vai ajudá-lo a compreender melhor:



A: gastrectomia total: 1-4;
gastrectomia subtotal: 2-4;
antrectomia: 3-4.
B: reconstrução a Billroth I (gastroduodenostomia).
C: Billroth II (gastrojejunostomia).
D: Y de Roux.



TRATAMENTO CLÍNICO DA ÚLCERA PERFURADA

Calma, não brigue comigo só porque eu disse que o tratamento da úlcera perfurada é cirúrgico! Mas, como tudo na medicina, há exceções, e algumas bancas adoram cobrá-las!

Nos casos de apresentação tardia, em que a perfuração foi bloqueada e o paciente está bem, estável, sem sinais de irritação peritoneal, nenhuma intervenção cirúrgica pode ser necessária. Mas, essa é uma conduta de exceção e feita em pacientes selecionados.

RESUMINDO

ABDOME AGUDO PERFURATIVO

Causa mais comum: úlcera péptica perfurada.

Fator de risco: infecção pelo *H. Pylori*, uso de anti-inflamatórios ou AAS.

Local mais comum: parede anterior do bulbo duodenal (1ª porção).

Clínica: dor abdominal súbita, de forte intensidade, taquicardia.

Exame físico: abdome tenso, em tábua, rigidez abdominal e sinais de peritonite difusa, RHA diminuídos.

Diagnóstico: pneumoperitônio à radiografia ou tomografia.

Tratamento: cirúrgico (laparotomia ou laparoscopia).

CAI NA PROVA

(PA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA BELÉM 2023) Homem de 72 anos chega ao pronto-socorro com dor abdominal difusa, de início súbito há 6 horas. Refere tabagismo e etilismo de longa data. Ao exame, observa-se regular estado geral, abdome em tábua, descompressão brusca presente nos quatro quadrantes e sinal de Jobert positivo. Sua hipótese diagnóstica e conduta nesse caso seriam:

A) úlcera gástrica perfurada; laparotomia exploradora.
B) pancreatite aguda; dosar amilase e lipase.
C) pancreatite aguda; tomografia de abdome.
D) úlcera gástrica perfurada; ultrassonografia de abdome.
E) colangite; ultrassonografia de abdome.

Comentários

Temos um paciente, etilista e tabagista, com quadro clínico típico de abdome agudo perfurativo, inclusive com o sinal de Jobert positivo. A próxima conduta é realizar a rotina radiológica de abdome agudo e, se visualizado pneumoperitônio, indicar o tratamento cirúrgico, ou seja, laparotomia exploradora.

O principal diagnóstico diferencial da úlcera péptica perfurada é a pancreatite aguda, que não apresenta sinal de Jobert ao exame físico. Na colangite aguda, o paciente apresenta a famosa tríade de Charcot: dor abdominal, febre e icterícia.

Gabarito: alternativa A.

(RS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA) 2023) Paciente feminina, de 80 anos, tabagista, com demência leve, usuária crônica de anti-inflamatório não esteroidal por artrose do joelho, foi trazida à emergência por dor abdominal difusa com início há 36 horas, sinais de irritação peritoneal, taquicardia, hipotensão, confusão mental e sinais de má perfusão periférica. Uma vez estabelecido o diagnóstico de abdômen agudo perfurativo, quais são a principal hipótese diagnóstica, a abordagem cirúrgica e o tratamento?

A) Úlcera péptica perfurada – videolaparoscopia – ulcerorrafia com vagotomia troncular.
B) Úlcera péptica perfurada – laparotomia – ulcerorrafia.
C) Isquemia intestinal – videolaparoscopia – enterectomia.
D) Diverticulite aguda perfurada – laparotomia – colectomia com colostomia (sem anastomose).

Comentário

Paciente tabagista, com relato de uso crônico de AINE, evoluindo com quadro clínico sugestivo de abdome agudo perfurativo com 36 horas de evolução e que já se apresenta com instabilidade hemodinâmica. A conduta, nesse caso, é laparotomia e ulcerorrafia com patch de Graham.

Incorreta a alternativa A: a laparoscopia está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica. Além disso, a vagotomia não deve ser realizada em pacientes instáveis.

Correta a alternativa B: essa é a conduta correta.

Incorreta a alternativa C: na isquemia intestinal, geralmente, a dor abdominal é de forte intensidade, mas é desproporcional ao exame físico (sem peritonite).
Incorreta a alternativa D: diverticulite aguda cursa com dor na fossa ilíaca esquerda.

(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SP 2022) Um homem de cinquenta anos de idade, etilista e tabagista, chega ao pronto-socorro por dor abdominal difusa iniciada há cerca de 30 minutos. Ele foi levado pelo médico da unidade básica de saúde, que fez o primeiro atendimento. Esse médico, além das informações clínicas sobre o caso, levou consigo uma radiografia de abdome, que mostrava uma lâmina aérea entre o fígado e o diafragma. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para o paciente.

A) Endoscopia digestiva alta.
B) Tomografia computadorizada de abdome.
C) Dosagem de amilase e lipase.
D) Laparotomia exploradora.
E) Passagem de sonda nasogástrica e reavaliação.

Comentário

Mais um quadro clínico típico de abdome agudo perfurativo com diagnóstico confirmado pela radiografia de abdome que demonstra pneumoperitônio **(lâmina aérea entre o fígado e o diafragma). Conduta nesse caso: tratamento cirúrgico, que pode por laparotomia ou laparoscopia se o paciente estiver estável hemodinamicamente.**

Gabarito: alternativa D



(SUS SP 2019) Um homem de 34 anos é atendido na sala de emergência por dor abdominal de início súbito, muito intensa, há 1 dia. Está torporoso. Pulso: 120 bpm, regular; PA: 60 × 40 mmHg. O abdome é em tábua, com claros sinais de peritonismo. Temperatura: 38 °C. Fez a radiografia ilustrada a seguir. Conduta, além de receber sintomáticos e antibióticos de amplo espectro:

A) Laparoscopia de emergência, com reanimação volêmica em sala operatória.
B) Tomografia de abdome e pelve, para melhor definir a conduta.
C) Reanimação volêmica com cristaloide e droga vasoativa; na sequência, laparotomia.
D) Laparotomia de emergência com reanimação volêmica durante a anestesia.
E) Reanimação exclusivamente com soro fisiológico, seguida de laparoscopia.

Comentário:

Temos aqui um típico quadro de abdome agudo perfurativo! Dor abdominal súbita, de forte intensidade, abdome em tábua e pneumoperitônio visto à radiografia de tórax. **Não é necessário nenhum exame de imagem adicional** para se indicar o tratamento cirúrgico de emergência, que deverá ser feito por meio de uma laparotomia, já que a presença de **instabilidade hemodinâmica é contraindicação absoluta à laparoscopia**. Mas, repare que nosso paciente não está bem, apresenta hipotensão, taquicardia, está torporoso, febril, com abdome em tábua e irritação peritoneal, sinais sugestivos de uma sepse de foco abdominal. Antes da cirurgia, devemos tentar melhorar as condições clínicas do paciente que está grave, e isso é feito de maneira rápida, por meio de reposição volêmica com cristaloide, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, início dos antibióticos de largo espectro, uso de drogas vasoativas (se necessário) e passagem de sonda vesical de demora para controle de diurese. Claro que essa reanimação volêmica deve ser mantida no intraoperatório.

Gabarito: alternativa C

(SANTA CASA 2020) Um paciente de 34 anos de idade foi ao pronto-socorro por dor abdominal de forte intensidade há duas horas. No exame físico de entrada, apresentava abdome em tábua. Realizou radiografia de tórax, que mostrou cúpulas com presença de pneumoperitônio. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta em relação ao abdome agudo perfurativo.

A) Nunca é possível tratar abdome agudo perfurativo por videolaparoscopia.

B) Nas úlceras gástricas perfuradas maiores e muito infiltrativas, a conduta mandatória é realizar epiploplastia a Graham.

C) Nas úlceras duodenais perfuradas extensas, o tratamento de escolha é a duodenopancreatectomia parcial.

D) Nunca se pode fazer gastrectomia no abdome agudo perfurativo, devido ao alto risco de fístula duodenal.

E) Sempre se deve fazer gastrectomia nas úlceras gástricas perfuradas maiores de 2 cm com suspeita tumoral.

Comentário:

Incorreta a alternativa A: se o paciente estiver estável hemodinamicamente, o tratamento da úlcera perfurada pode ser por laparoscopia.
Incorreta a alternativa B: na presença de uma úlcera gástrica grande (≥ 2 cm) e infiltrativa, características de neoplasia, a melhor conduta é a gastrectomia englobando a úlcera e vagotomia troncular. Lembrando que é necessária estabilidade hemodinâmica para esse procedimento.
Incorreta a alternativa C: as opções cirúrgicas para o tratamento de uma úlcera duodenal extensa perfurada são a exclusão pilórica (rafia da úlcera com patch de omento ou de serosa jejunal, cerclagem do piloro com fio absorvível e uma gastroenteroanastomose a BII ou Y de Roux), colocação de um tubo pela úlcera (duodenostomia) ou antrectomia englobando a úlcera com reconstrução a BII ou Y de Roux.
Incorreta a alternativa D: se o paciente estiver estável e não houver sinais de peritonite difusa, podemos fazer o tratamento definitivo da úlcera, sendo uma das opções, a gastrectomia com ou sem vagotomia troncular, a depender da localização da úlcera.

Correta a alternativa E: se o paciente tiver condições de suportar uma gastrectomia e não houver peritonite difusa, realmente essa é a conduta de escolha na úlcera gástrica com suspeita de malignidade. Mas, não gosto dessa palavra "SEMPRE"; foi colocada só para confundir você! Ainda assim, é a melhor resposta!

(SUS SP 2017) Um homem de 39 anos de idade, tabagista e hipertenso, é operado por abdome agudo perfurativo. No intraoperatório, é achada úlcera perfurada em antro gástrico, com 2 cm de diâmetro, e peritonite purulenta difusa. Melhor conduta:

A) Sutura da úlcera e epiploplastia.
B) Antrectomia com vagotomia seletiva.
C) Gastrectomia parcial com reconstrução em Y de Roux.
D) Gastrectomia subtotal e reconstrução à BII.
E) Antrectomia com vagotomia troncular.

Comentário:

Nessa questão, faltou falar sobre as condições clínicas do paciente, ajudaria bastante. Mas, o autor foi claro quando colocou "peritonite purulenta difusa". Em pacientes instáveis, com peritonite difusa ou contaminação peritoneal significativa, que não suportariam uma cirurgia para o tratamento definitivo da úlcera por exigir maior tempo cirúrgico, devemos fazer apenas o fechamento da úlcera, epiploplastia e lavagem da cavidade. Não esquecer de biopsiar as bordas da úlcera para excluir neoplasia!

Se o cenário fosse outro, com o paciente bem, estável, sem peritonite e/ou contaminação abdominal, a conduta ideal seria a alternativa E: antrectomia e vagotomia troncular, com reconstrução a BI (mais fisiológico) ou BII ou em Y de Roux.

A vagotomia seletiva é um procedimento praticamente não utilizado atualmente, pela alta taxa de recidiva da doença ulcerosa.

Gabarito: alternativa A

(SANTA CASA SP 2015) Homem de 47 anos é admitido no PS com queixa de dor abdominal há 3 dias com piora súbita há 8 horas. Conta uso de diclofenaco (3 comprimidos ao dia) há 1 semana, por dor lombar após esforço físico. Refere ser nervoso, mas nega antecedente mórbido. Ao exame, apresentava-se gemente, taquicárdico, com abdome em tábua. RX com pneumoperitônio. Foi feita laparotomia exploradora cujo achado foi uma úlcera na região pré–pilórica com perfuração de 0,3 cm, sem calo ulceroso palpável, com líquido turvo na cavidade peritoneal. Das opções abaixo, a melhor para esse caso é:

A) Desbridamento da borda da úlcera seguida da ulcerorrafia e vagotomia troncular.
B) Ulcerorrafia com procedimento de Graham modificado e uso de bloqueadores de bomba de prótons.
C) Gastrectomia parcial e gastroduodenostomia associada ao uso de bloqueadores de bomba de prótons.
D) Gastrectomia parcial e gastrojejunostomia.
E) Gastrectomia parcial e reconstrução a Billroth II associada ao uso de bloqueadores de bomba de prótons.

Comentário:

Temos um paciente que fez uso de anti-inflamatórios (diclofenaco) por uma semana e evoluiu com abdome agudo perfurativo. No intraoperatório, foi identificada uma úlcera pré-pilórica de 0,3cm, sem calo ulceroso, o que nos sugere uma úlcera muito aguda e que, provavelmente, surgiu devido ao uso do anti-inflamatório. Na classificação de Johnson, ela é uma úlcera tipo V, e como a hipercloridria não é o fator desencadeante da úlcera e as características não sugerem malignidade, **não há necessidade de vagotomia ou gastrectomia.** Dessa forma, o tratamento a ser realizado consiste apenas em rafia da úlcera e epiploplastia (técnica de Graham). No pós-operatório, é indicado o uso do inibidor de bomba de prótons e descontinuar o uso de anti-inflamatórios.

Gabarito: alternativa B

(CERMAM – 2017) Sobre a úlcera péptica perfurada todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

A) O exame físico abdominal mostra sinal de irritação peritoneal.

B) A radiografia de tórax em ortostase mostra pneumotórax livre.

C) Quase sempre o paciente pode dar a hora exata do início da dor lancinante.

D) O tratamento clínico é indicado apenas quando há evidências de que a ferida tenha se fechado e na ausência de peritonite química.

Comentário:

Eu só coloquei essa questão aqui para mostrar a você que algumas bancas cobram sobre o tratamento conservador da úlcera péptica perfurada. Vamos às alternativas:

Correta a alternativa A: irritação peritoneal é comum, principalmente se a perfuração for livre para cavidade abdominal.

Incorreta a alternativa B: a radiografia mostra pneumoperitônio, não pneumotórax.

Correta a alternativa C: como a dor é muito súbita e aguda, o paciente costuma dizer o horário exato da perfuração.

Correta a alternativa D: o tratamento clínico pode ser indicado nas apresentações tardias, bloqueadas, no paciente em bom estado geral, estável e sem sinais de peritonite. A qualquer sinal de piora clínica, o paciente deve ser operado.

CAPÍTULO

2.0 OUTRAS CAUSAS DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO

Meu querido aluno, mais de 90% das questões de abdome agudo perfurativo são sobre úlcera péptica perfurada. Mas a perfuração de qualquer víscera oca, intra ou retroperitoneal pode levar ao mesmo diagnóstico sindrômico. As manifestações clínicas são semelhantes, com dor abdominal súbita, de forte intensidade, geralmente acompanhada de sinais sistêmicos, como taquicardia, taquipneia, hipotensão, sudorese e sinais de peritonite ao exame físico. A intensidade e localização da dor dependem do órgão afetado e do conteúdo liberado. O diagnóstico de perfuração intestinal é confirmado por exames de imagem que demonstrem pneumoperitônio ou retropneumoperitônio, mas, ocasionalmente, pode ser necessária a laparotomia ou laparoscopia para o diagnóstico.

O tratamento inicial de toda perfuração é feito com as medidas de suporte, ou seja, jejum, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, analgesia, início dos antibióticos. E o tratamento específico depende da doença que causou a perfuração, sendo que **na maioria dos casos há indicação de cirurgia de urgência e reparo da lesão**, mas algumas etiologias são passíveis de abordagem não cirúrgica.

Vou colocar aqui algumas causas de perfuração intestinal:

IATROGENIA (INSTRUMENTAÇÃO/CIRURGIA): a instrumentação do trato gastrointestinal é a principal causa de perfuração iatrogênica e pode incluir endoscopia digestiva alta (especialmente endoscopia rígida), sigmoidoscopia, colonoscopia, colocação de *stent*, escleroterapia endoscópica, intubação nasogástrica, dilatação esofágica e cirurgia (uso excessivo e inadvertido do eletrocautério). Outros procedimentos também podem ser complicados com a perfuração, como drenagem torácica baixa, inserção de cateter de diálise peritoneal, gastrostomia percutânea, paracentese, lavagem peritoneal diagnóstica e drenagem percutânea de abscessos intracavitários.

Nos casos de perfuração colônica após colonoscopia, se o diagnóstico e a indicação cirúrgica forem feitos de forma rápida, não haverá grande contaminação intracavitária, podendo ser realizada apenas sutura primária da lesão, sem necessidade de ressecção intestinal.

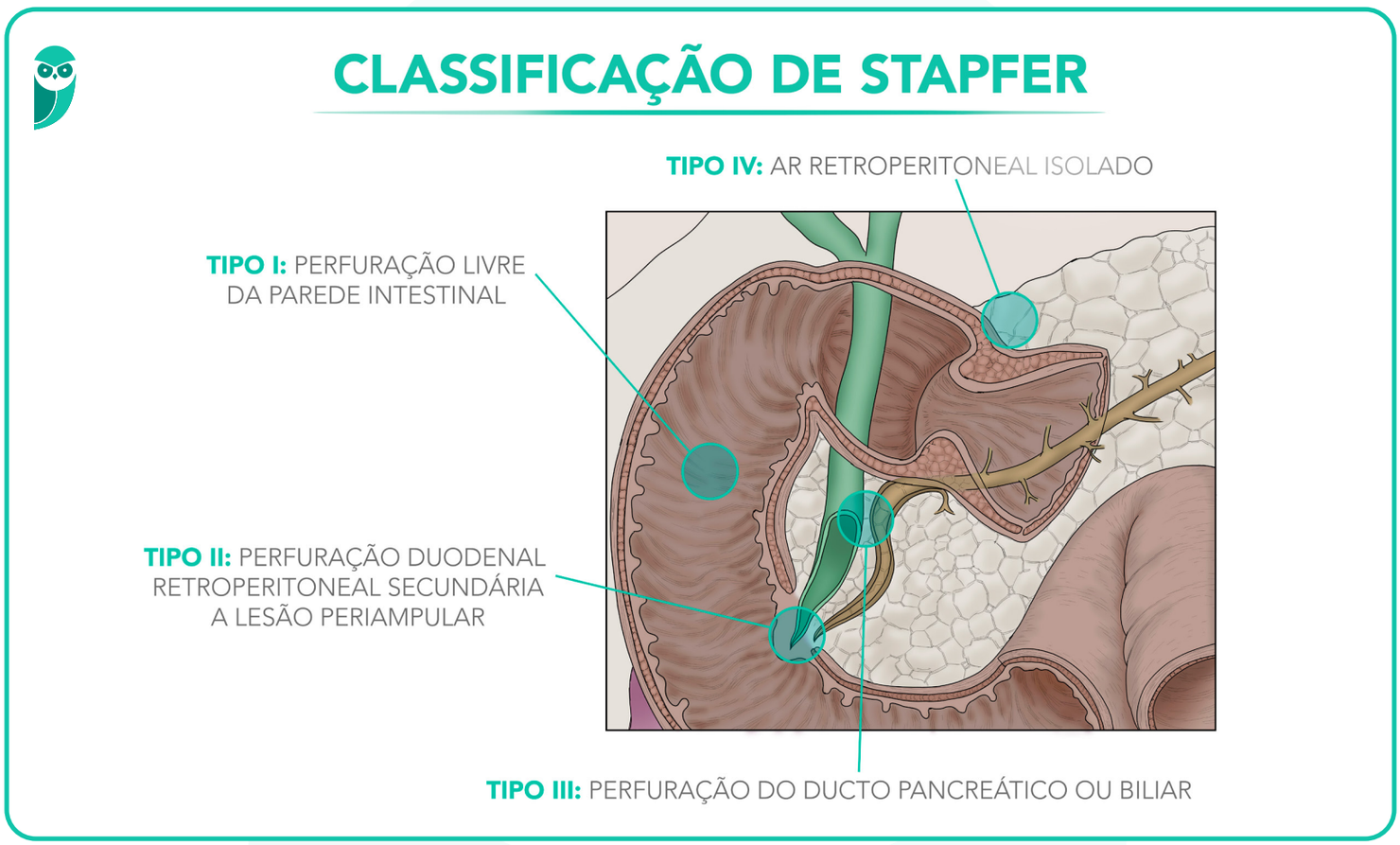
PÓS-CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica): a CPRE é um exame invasivo que apresenta complicações, como pancreatite aguda (mais comum), colangite, **perfuração duodenal** e sangramento, quando a esfincterotomia é realizada. Vou colocar aqui a classificação de Stapfer, que embora não seja cobrada diretamente nas provas, seu conhecimento ajuda na tomada de condutas e, assim, auxilia na resolução das questões. Essa classificação refere-se à perfuração duodenal após a CPRE, e é baseada no mecanismo, localização anatômica e gravidade da lesão e pode indicar a necessidade de intervenção cirúrgica.



CLASSIFICAÇÃO DE STAPFER

- Tipo I: perfuração livre da parede intestinal;
- Tipo II: perfuração duodenal retroperitoneal secundária à lesão periampular (mais comum, geralmente após papilotomia);
- Tipo III: perfuração do ducto pancreático ou biliar;
- Tipo IV: ar retroperitoneal isolado.

Observe na imagem abaixo para entender melhor essa classificação:



O tratamento para todos os tipos de lesão inclui jejum, hidratação endovenosa, passagem de nasogástrica (SNG) e antibióticos endovenosos. Os pacientes que necessitem de repouso intestinal por uma semana devem receber nutrição parenteral. Perfurações livres para cavidade abdominal geralmente necessitam de tratamento cirúrgico de urgência. Já perfurações retroperitoneais, sem repercussões sistêmicas, podem ser tratadas clinicamente com as medidas descritas acima. Se o paciente não apresentar boa resposta clínica, ou houver piora, deverá ser operado.

CORPO ESTRANHO: corpos estranhos, como objetos pontiagudos (palitos de dente, pregos), alimentos com superfícies pontiagudas (por exemplo, ossos de galinha, peixe) ou bezoar, podem causar perfuração do trato gastrointestinal. Devemos estar atentos aos pacientes psiquiátricos!

OBSTRUÇÃO: na obstrução intestinal, principalmente na obstrução em alça fechada (dois pontos do intestino encontram-se ocluídos simultaneamente), à medida que há um aumento da pressão intraluminal proximal ao ponto obstrutivo, ocorre isquemia, necrose e consequente perfuração. Um exemplo clássico é a obstrução de cólon esquerdo por neoplasia com válvula ileocecal competente, em que se forma uma obstrução em alça fechada, com um maior risco de perfuração de ceco (local mais comum de perfuração nesses casos). Dessa forma, qualquer processo de obstrução intestinal que não seja tratado, pode levar à isquemia, necrose e, consequentemente, perfuração intestinal.

ISQUEMIA → NECROSE → PERFURAÇÃO → PERITONITE

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO: processos inflamatórios intracavitários, como apendicite e diverticulite aguda, podem cursar com perfuração e formação de abscessos bloqueados ou peritonite difusa.

ABDOME AGUDO VASCULAR: a presença de isquemia intestinal pode evoluir com perfuração se não tratada adequadamente.

DOENÇA INFECCIOSA: febre tifoide, tuberculose, esquistossomose, citomegalovírus (principalmente em imunodeprimidos) podem causar perfuração do intestino delgado.



FEBRE TIFOIDE

A febre tifoide, ou febre entérica, é uma doença infecciosa potencialmente grave, causada pela *Salmonella typhi*, uma bactéria Gram-negativa da família *Enterobacteriaceae*. É mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens. A transmissão da febre tifoide é fecal-oral, por isso é mais frequente em áreas endêmicas e sem saneamento básico. Os principais sintomas são febre alta e prolongada (sintoma mais comum), cefaleia, prostração, fadiga, dor abdominal, exantema no tórax e abdome (roséola tífica), podendo apresentar diarreia ou constipação e evoluir com confusão mental e óbito (até 15% dos casos). O tratamento é baseado em antibioticoterapia. As principais complicações são a hemorragia digestiva (3% a 10%) e a perfuração intestinal (3%), que geralmente ocorre em um único local no íleo terminal (nas manchas necróticas de Peyer).

CAI NA PROVA

(HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA – HOS 2019) Homem de 55 anos de idade foi submetido à colonoscopia de controle. O preparo intestinal estava adequado e foi encontrado um pólipo de 1 cm, pediculado e de aspecto benigno. Foi realizada polipectomia e o pólipo enviado para exame anatomopatológico. Após quatro horas do procedimento, o paciente desenvolve distensão e dor abdominal importante em flanco esquerdo. Realizada TC de abdômen e pelve, que mostra ar livre intraperitoneal e borramento da gordura junto ao sigmoide. Indicada laparotomia exploradora, que mostra lesão única localizada na borda contra mesenterial do cólon sigmoide. Nesse caso, dentre as possíveis condutas a seguir, a melhor conduta é:

A) colostomia proximal de proteção.
B) sutura primária da perfuração.
C) colectomia tipo Hartmann.
D) sigmoidectomia com anastomose primária.
E) drenagem da lesão com dreno fechado e de aspiração contínua.

Comentário:

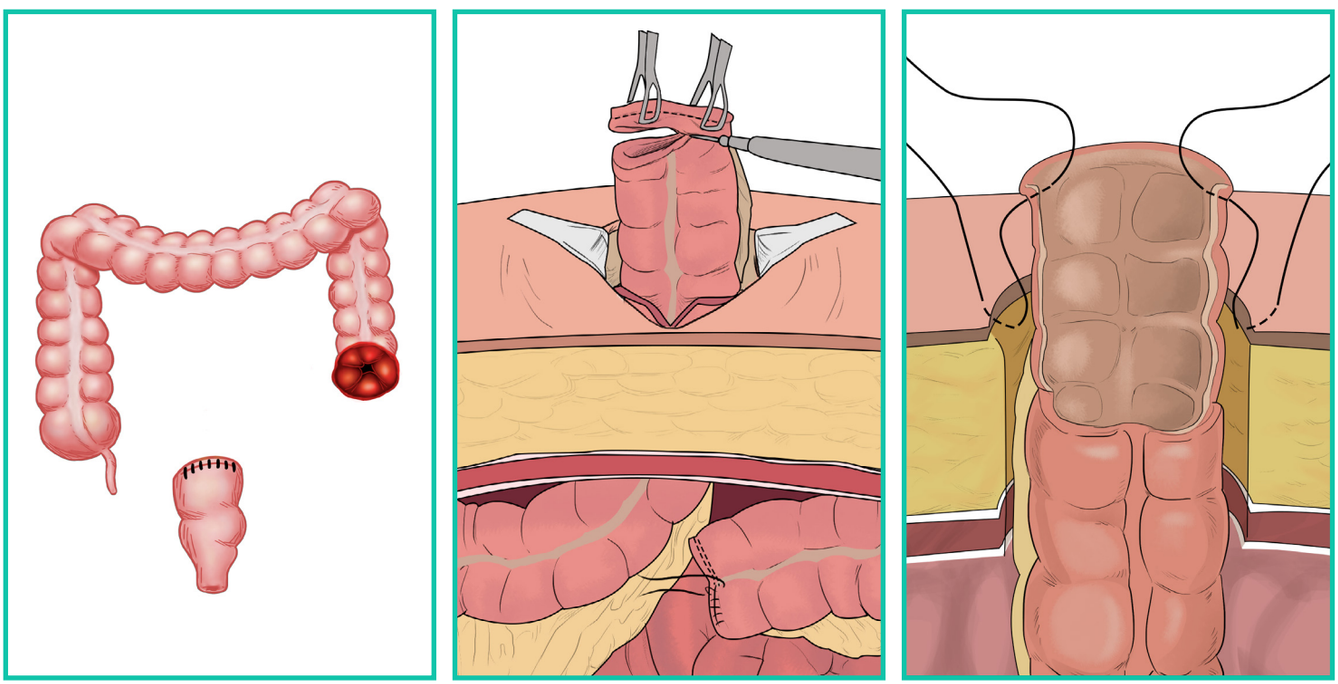
Temos um paciente com um quadro de abdome agudo perfurativo após colonoscopia e polipectomia, pois a tomografia realizada após 4 horas do procedimento evidenciou pneumoperitônio (ar livre intraperitoneal) e borramento da gordura perissigmoideana (local da perfuração). Na laparotomia, foi visualizado apenas o local da perfuração no sigmoide e não está descrito grande contaminação da cavidade, que realmente deve estar ausente, pois o diagnóstico foi dado precocemente. Nesses casos, a conduta é realizar apenas sutura primária da lesão aguda, sem necessidade de ressecção intestinal.

Incorreta a alternativa A: uma colostomia proximal de proteção tem indicação quando se faz uma ressecção com anastomose intestinal, com o intuito de desviar o trânsito intestinal. Não é uma cirurgia que se faça "isoladamente".

Correta a alternativa B: diante de uma lesão aguda, com pouco tempo de evolução e sem contaminação grosseira da cavidade, estamos autorizados a realizar apenas sutura da lesão colônica.

Incorreta a alternativa C: a cirurgia de Hartmann consiste em ressecção intestinal, colostomia proximal e sepultamento do coto retal. Não há necessidade de ressecção intestinal. Ela estaria indicada na presença de peritonite difusa, com contaminação fecal, o que ocorre geralmente nos diagnósticos mais tardios.

CIRURGIA DE HARTMANN



Incorreta a alternativa D: não há indicação de ressecção intestinal para lesões agudas e pequenas. Uma sigmoidectomia com anastomose poderia estar indicada em lesões mais extensas e sem contaminação da cavidade. Por exemplo, na ausência de contaminação grosseira da cavidade, as lesões colônicas por trauma abdominal, maiores que 50% da circunferência, têm indicação de ressecção e anastomose, e nas lesões menores que 50% da circunferência, a conduta é rafia primária.

Incorreta a alternativa E: a lesão deve ser reparada, e não drenada!

(IAMSPE 2019) Paciente de 82 anos realizou colangiografia endoscópica com papilotomia e extração de cálculo de 0,9 cm (litíase residual). Após 24 horas, apresentava dor abdominal, náuseas e vômitos. Exame físico em bom estado geral, frequência cardíaca de 84 bpm, e dor epigástrica à palpação profunda. Realizou leucograma de 12000 leucócitos/mm³ e hemoglobina de 12g/dL, amilase de 880 UI, e proteína C reativa (PCR) de 14 MG/L. Foi solicitada tomografia abdominal e detectou somente mínima quantidade de ar periduodenal, com demais achados normais. A conduta correta é:

A) tratamento clínico com analgésico, jejum e nutrição parenteral devido à pancreatite aguda.
B) tratamento clínico com antibioticoterapia, jejum e nutrição parenteral para a complicação do procedimento.
C) tratamento cirúrgico imediato com desbridamento local e limpeza pancreática.
D) tratamento endoscópico com cateterização da papila e passagem de prótese.
E) tratamento cirúrgico com colocação de dreno Kehr na via biliar.

Comentários:

Temos uma paciente submetida à CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) e papilotomia com retirada de cálculo, evoluindo com dor abdominal, náuseas e vômitos. Os exames laboratoriais mostram um aumento importante da amilase (sugestiva de pancreatite aguda) e sinais de perfuração duodenal (mínima quantidade de ar periduodenal).

As complicações mais comuns após a CPRE são a pancreatite aguda, perfuração duodenal e hemorragia digestiva alta. Nossa paciente apresenta duas complicações concomitantes!

Com relação à pancreatite aguda, o tratamento é clínico, com jejum, hidratação endovenosa e analgesia. E em relação à perfuração duodenal, precisa operar? Para isso existe a classificação de Stapfer para perfuração duodenal pós-CPRE, que é baseada no mecanismo, localização anatômica e gravidade da lesão que pode predizer a necessidade de intervenção cirúrgica.

- Tipo I: perfuração livre da parede intestinal;
- Tipo II: perfuração duodenal retroperitoneal secundária à lesão periampular (mais comum);
- Tipo III: perfuração do ducto pancreático ou biliar; e
- Tipo IV: ar retroperitoneal isolado.

As perfurações retroperitoneais, sem repercussões sistêmicas (caso do nosso paciente), podem ser tratadas clinicamente com jejum, hidratação endovenosa, aspiração nasogástrica (SNG), antibióticos endovenosos e nutrição parenteral. Se o paciente não apresentar boa resposta clínica ou houver piora, deverá ser operado.

Incorreta a alternativa A: a conduta está correta, mas nutrição parenteral está indicada devido à perfuração duodenal, e não por causa da pancreatite aguda.

Correta a alternativa B: como temos uma provável perfuração retroperitoneal duodenal, identificada pela tomografia como "mínima quantidade de ar periduodenal", sem repercussão clínica (sem peritonite, febre e/ou leucocitose), devemos deixar o trato gastrointestinal em repouso, por meio da nutrição parenteral total. Também é necessário antibioticoterapia de largo espectro nas perfurações duodenais.

Incorreta a alternativa C: indicação de tratamento cirúrgico da pancreatite aguda é na presença de necrose infectada (necrosectomia). Nesses casos, o paciente encontra-se gravemente enfermo, com repercussão sistêmica, e indicativos de necrose pancreática infectada na tomografia.

Incorreta a alternativa D: nosso paciente apresenta duas complicações da CPRE: a pancreatite aguda e a perfuração duodenal. Submetê-lo a outra CPRE, certamente irá agravar o quadro clínico. Além disso, a passagem de endoprótese está indicada para obstrução da via biliar, por exemplo, em neoplasias do colédoco distal.

Incorreta a alternativa E: a indicação de drenagem cirúrgica de urgência da via biliar com dreno de Kher é na vigência de colangite aguda, na falha ou indisponibilidade da CPRE. A colangite aguda ocorre nos casos de obstrução da via biliar, geralmente por coledocolitíase. O paciente apresenta dor abdominal, febre e icterícia, conhecida como tríade de Charcot.

(CERMAN 2010) Paciente do sexo masculino, 25 anos, apresenta história de dor abdominal há 2 semanas. O paciente é residente de comunidade ribeirinha e faz uso de água não tratada, do rio, iniciou quadro de dor abdominal em cólicas e febre alta que evoluiu com diarreia esverdeada franca e desidratação severa. Foi encaminhado a Manaus e foi internado em unidade básica de saúde sendo tratado com cloranfenicol por 7 dias, sem melhora satisfatória. Hoje apresentou piora súbita da dor abdominal, inicialmente mesogástrica, que posteriormente irradiou para todo o abdome e ombro esquerdo, há cerca de 6 horas. Apresentou vômitos. Ao exame físico apresenta-se febril, sudoreico, com mucosas secas e taquicárdico e discretamente hipotenso. O paciente encontra-se imóvel na maca, com respiração rápida e superficial. O abdome é difusamente doloroso à palpação e muito tenso. Blumberg positivo. O hematócrito era 32%, a hemoglobina 10 mg/dl e o leucograma é de 15.000 leucócitos com 90% de neutrófilos. Marque a alternativa correta:

A) Trata-se de abdome agudo inflamatório já que o paciente apresenta quadro de evolução arrastada, acompanhado de febre e leucocitose, estando indicada a transferência para UTI para compensação do quadro prévia à laparotomia.

B) Já que o caso tem 2 semanas de evolução seu tratamento não deve ser cirúrgico, sendo a conduta mais adequada a troca do antibiótico e hidratação vigorosa do paciente.

C) Trata-se de abdome agudo hemorrágico já que o paciente apresenta hipotensão e taquicardia, estando indicada a transfusão sanguínea e laparotomia imediata.

D) A radiografia de tórax provavelmente indicará laparotomia exploradora para o paciente acima.

E) Com os dados acima podemos afirmar que se trata de abdome agudo cirúrgico por úlcera péptica perfurada, já que o paciente apresenta abdome em tábua e irradiação da dor para o ombro.

Comentários:

Temos um paciente jovem que foi internado por um quadro arrastado de febre alta, dor abdominal e diarreia. Repare que ele é residente de uma área "ribeirinha" sem saneamento básico, onde há maior incidência de febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, uma bactéria Gram-negativa da família Enterobacteriaceae. A transmissão da febre tifoide é fecal-oral, por isso é mais frequente em áreas endêmicas e sem saneamento básico. Os principais sintomas são febre alta e prolongada (sintoma mais comum), dor abdominal, exantema no tórax e abdome (roséola tífica), podendo apresentar diarreia ou constipação e evoluir com confusão mental. Uma das complicações é a perfuração intestinal, que geralmente ocorre no íleo terminal.

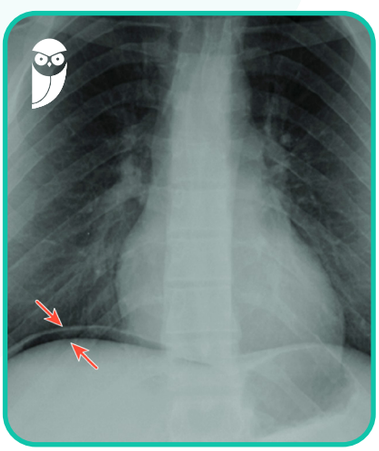
Dito isso, nossa principal hipótese diagnóstica é uma febre tifoide, complicada, com uma perfuração intestinal. O paciente não apresentou melhora com o uso de antibioticoterapia após 7 dias e evoluiu com dor abdominal súbita, com sinais de choque (taquicardia, taquipneia, hipotensão), apresentando abdome "em tábua", tenso e com sinais de peritonite (sinal de Blumberg positivo), quadro clínico clássico de um abdome agudo perfurativo. Agora vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: a característica da dor súbita e com rápida repercussão sistêmica não condiz com abdome agudo inflamatório, e sim com um abdome agudo perfurativo, cujo tratamento é laparotomia de emergência, após reanimação volêmica.

Incorreta a alternativa B: o tratamento do abdome agudo perfurativo é cirúrgico de emergência!

Incorreta a alternativa C: a presença de febre e leucocitose falam contra um abdome agudo hemorrágico.

Correta a alternativa D: na radiografia de tórax PA (póstero-anterior) em ortostase, é possível visualizar o pneumoperitônio, ou seja, ar sob o diafragma. Esse exame confirma nossa hipótese diagnóstica de uma perfuração intestinal, o suficiente para indicar o tratamento cirúrgico.



Incorreta a alternativa E: nossa principal hipótese diagnóstica é um abdome agudo perfurativo e, com o quadro clínico do nosso paciente sugerindo o diagnóstico de febre tifoide, devemos pensar em uma perfuração de íleo terminal, e não de uma úlcera péptica perfurada.

CAPÍTULO
3.0 OUTRAS CAUSAS DE PNEUMOPERITÔNIO

PNEUMOPERITÔNIO PÓS-CIRÚRGICO

Devemos lembrar que é esperada a presença de pneumoperitônio no pós-operatório de uma cirurgia abdominal. Após 24 horas de uma laparoscopia, aproximadamente 40% dos pacientes terão mais de 2 cm de pneumoperitônio. Já no pós-operatório de uma laparotomia, o pneumoperitônio geralmente pode ser visto em uma radiografia até uma semana, mas o volume deve diminuir gradualmente com o tempo. Dessa forma, quantidades crescentes de ar extraluminal durante um período de observação são preocupantes e podem sugerir perfuração intestinal, até prova em contrário.

PNEUMOPERITÔNIO NÃO CIRÚRGICO

O pneumoperitônio é causado frequentemente por perfurações de vísceras ocas, entretanto, em aproximadamente 10% dos casos, pode estar presente na ausência de perfuração intestinal. Dessa forma, uma etiologia não cirúrgica pode ser a causa do pneumoperitônio. É possível a identificação de pneumoperitônio em pacientes sem queixa de dor abdominal, diagnosticado, por exemplo, em uma tomografia. Em pacientes em ventilação mecânica, o pneumoperitônio pode ser causado por pressão positiva contínua nas vias aéreas ou pressão expiratória final positiva (PEEP). Colocação de gastrostomia percutânea endoscópica, paracentese, diálise peritoneal, instrumentação vaginal, abscesso pulmonar e ruptura de alvéolos pulmonares também podem causar pneumoperitônio. Ocasionalmente, a peritonite bacteriana tem sido associada ao pneumoperitônio, que é importante distinguir em pacientes cirróticos, uma vez que a laparotomia exploradora está associada a uma taxa de mortalidade de aproximadamente 80% nessa população de pacientes.

PNEUMOPERITÔNIO IDIOPÁTICO

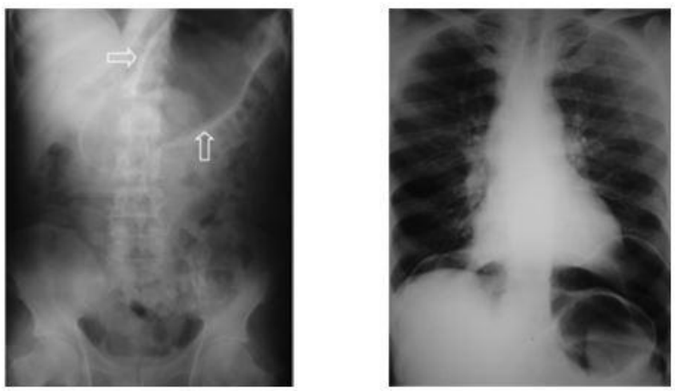
O pneumoperitônio idiopático é uma condição rara e constitui um diagnóstico de exceção. Quando nenhuma causa é encontrada para o achado de um pneumoperitônio, ele é definido como idiopático.

É válido ressaltar que, frente a um caso de pneumoperitônio identificado nos exames de imagem, ainda devemos manter a clássica conduta de tratamento cirúrgico, independentemente de sua etiologia, sem gerar para isso maior morbimortalidade ao paciente, visto que os riscos inerentes à laparotomia exploradora não suplantam os riscos de se deixar uma possível causa de pneumoperitônio sem tratamento.

CAI NA PROVA

(HIAE 2020) Um paciente de 45 anos procurou o pronto-socorro de hospital terciário, que tem todos os recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis, com dor abdominal há aproximadamente 24 horas, tipo pontada. A dor inicialmente era em região infraumbilical e de pequena intensidade. Tornou-se progressivamente mais intensa, passando a irradiar-se para o tórax e para o ombro direito. Negava outros fatores concomitantes. Estava em bom estado geral, mas tinha alteração do pulso, que tinha frequência de 120 bpm. O abdome era doloroso difusamente à palpação profunda, com sinal de Jobert presente, mas sem sinais de irritação peritoneal. Negava antecedentes médicos relevantes. Negava laparotomia, tabagismo, uso de medicações ou drogas ilícitas. Referia apenas ingesta alcoólica habitual (cerca de 20 g de álcool etílico/dia). Dos exames de laboratório solicitados, apenas o leucograma estava alterado: 17.580 leucócitos/mm³, sem desvio à esquerda. As radiografias, ilustradas a seguir, mostraram pneumoperitônio de grandes proporções. Foi indicada laparotomia exploradora. Na abertura da cavidade abdominal (incisão mediana), identificou-se saída de grande quantidade de gás, logo após a incisão do peritônio. Não se achou contaminação, nem líquido entérico. No inventário da cavidade, procedeu-se à inspeção e palpação de todos os órgãos, incluindo diafragma, estômago (foi explorada a retrocavidade dos epíplons), duodeno (após manobra de Kocher), intestino delgado e grosso (após

descolamento de ambas as goteiras parietocólicas). Nenhuma alteração foi encontrada. Por fim, através da sonda nasogástrica, foi insuflado ar no estômago e não ocorreu escape aéreo. Foi ainda injetado azul de metileno, que também não extravasou para a cavidade peritoneal. Com relação à conduta adotada, é correto afirmar:



A) A conduta foi correta, uma vez que os riscos inerentes ao procedimento não suplantam os riscos de se deixar possível causa de pneumoperitônio sem tratamento.

B) Deveria ter sido submetido antes a colonoscopia, para afastar a presença de cistos no cólon.

C) O paciente não deveria ter sido operado, pois seu pneumoperitônio é claramente idiopático.

D) Deveria ter sido submetido antes a endoscopia digestiva alta, pois a principal hipótese diagnóstica era úlcera perfurada.

E) A tomografia de abdome com contraste poderia dispensar a intervenção cirúrgica.

Comentário:

Paciente de 45 anos com quadro de dor abdominal de início súbito e de forte intensidade. Apresentava abdome doloroso difusamente, porém sem descompressão dolorosa brusca. Apresentava taquicardia e leucocitose importante, sem desvio à esquerda. Radiografia com pneumoperitônio. Realizada laparotomia exploradora, sem identificação do fator causal. E agora? Vamos analisar as alternativas:

Correta a alternativa A: temos um paciente com dor abdominal aguda, taquicardia, leucocitose e pneumoperitônio à radiografia simples de tórax e abdome, inclusive apresenta o sinal de Rigler na incidência abdominal, indicativo de pneumoperitônio. Nesses casos, nossa principal hipótese diagnóstica é uma perfuração de víscera oca intraperitoneal, e a conduta é cirurgia de urgência. Apesar de não ter sido encontrada nenhuma alteração na exploração intracavitária, os riscos inerentes à laparotomia exploradora não suplantam os riscos de se deixar uma possível causa de pneumoperitônio sem tratamento. Por isso, a conduta estava correta.



Sinal de Rigler ou sinal da dupla parede = pneumoperitônio.

Incorreta a alternativa B: na presença de pneumoperitônio, em que suspeitamos de perfuração de víscera oca, está contraindicado a colonoscopia, já que o exame injeta ar no cólon e pode piorar ou desbloquear uma perfuração. Além disso, uma perfuração colônica seria identificada durante a cirurgia.

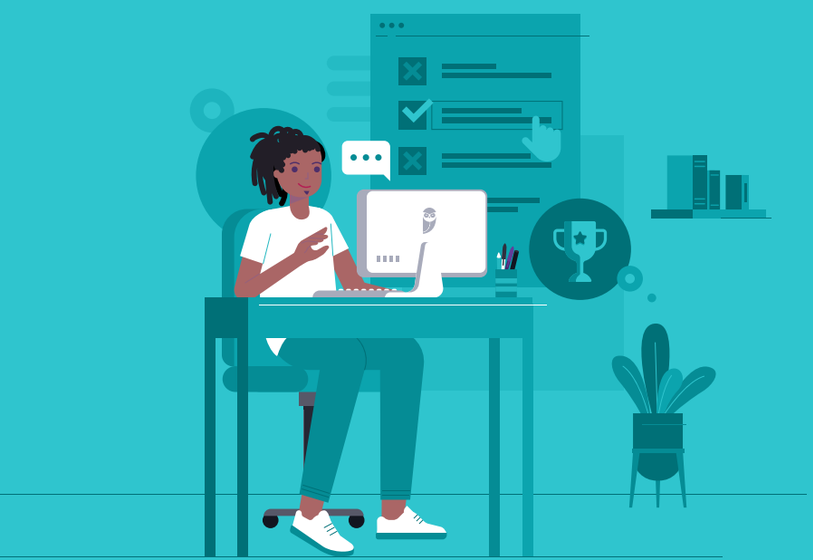
Incorreta a alternativa C: pneumoperitônio idiopático é um diagnóstico de exceção. E como foi dito anteriormente, os riscos inerentes à laparotomia exploradora não suplantam os riscos de se deixar uma possível causa de pneumoperitônio sem tratamento.

Incorreta a alternativa D: na suspeita de úlcera péptica perfurada, não está indicada a endoscopia, já que a insuflação de ar pode desbloquear uma perfuração bloqueada e piorar a peritonite.

Incorreta a alternativa E: se o paciente realizasse uma tomografia, essa também demonstraria o pneumoperitônio, e a indicação cirúrgica não mudaria.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3sfOti3

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. UpToDate:
   - 2.1. Visão geral da perfuração do trato gastrointestinal.
   - 2.2. Úlcera péptica: manifestações clínicas e diagnóstico.
   - 2.3. Visão geral das complicações da úlcera péptica.
   - 2.4. Tratamento cirúrgico da úlcera péptica.
   - 2.5. Vagotomia.

CAPÍTULO

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos mais um capítulo sobre abdome agudo. Coloquei aqui as principais patologias que podem cursar com perfuração intestinal. Mas, dê uma atenção especial à perfuração por úlcera péptica, pois essa é a principal causa de abdome agudo perfurativo, por isso a mais cobrada nas provas.

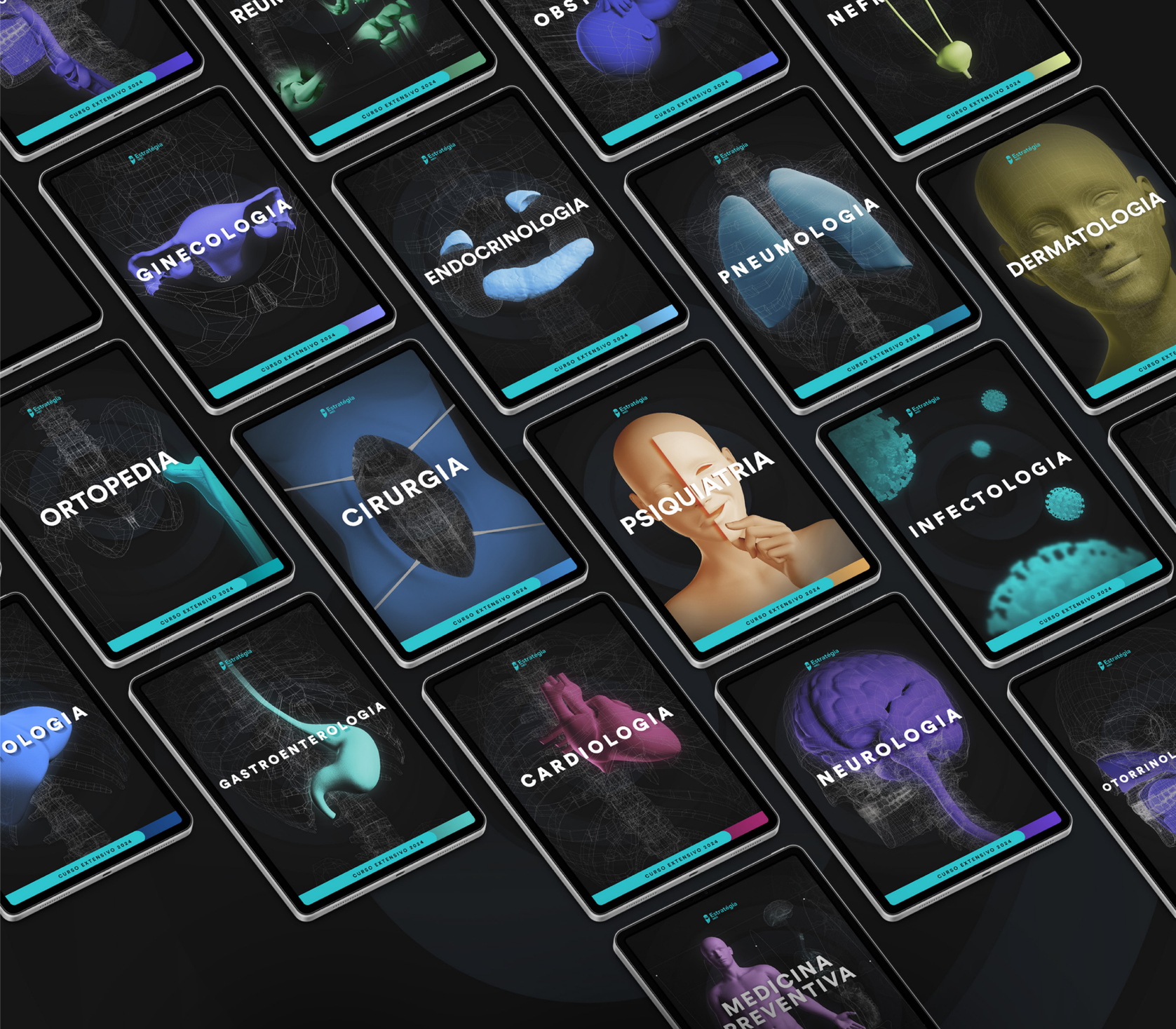
Lembre-se de que estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Não esqueça de nos seguir nas mídias sociais, @estrategiamed, @prof.renathapaiva, para ficar por dentro dos assuntos médicos mais atuais de todas as especialidades.

Bons estudos! E fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED